



RUMAH SAKIT
DHARMA HUSADA



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BPJS KETENAGAKERJAAN KANTOR CABANG PASURUAN
DENGAN
RUMAH SAKIT DHARMA HUSADA
TENTANG
PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN
BAGI PESERTA PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA**

Nomor: PER/ ... /.... (nomor PIHAK PERTAMA)

Nomor: (nomor PIHAK KEDUA)

Pada hari ini ... (nama hari) tanggal ... (00-00-0000) di ..., yang bertanda tangan di bawah ini:

I. BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Pasuruan : Suatu Badan Hukum Publik yang didirikan berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dalam hal ini diwakili oleh **SULISTIJO NISITA WIRJAWAN** dalam jabatannya selaku Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pasuruan. Berdasarkan Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: **KEP/207/092024** tentang **Mutasi Pejabat** dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang **Pasuruan** yang berkedudukan di **Jl. Ir. H. Juanda Nomor 77, Bugul Lor, Pasuruan**, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

II. RUMAH SAKIT : Suatu Rumah Sakit Swasta berada di bawah naungan PT **Dharma Husada HAF** yang didirikan berdasarkan Akta nomor 05, tanggal 05 (Lima) 05 (Mei) 2025 (Dua Ribu Dua Puluh Lima), dibuat dihadapan Rita Sutandio, S.H, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Probolinggo, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya Nomor AHU-AH.01.09-0235587. Tahun 2025 tertanggal 14 (Empat Belas) 05 (Mei) 2025 (Dua Ribu Dua Puluh

Lima) selaku Badan Usaha pengelola Rumah Sakit Dharma Husada dalam hal ini diwakili oleh **dr. Ifit Bagus Apriantono, M.MRS** selaku Direktur Rumah Sakit Dharma Husada dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Keputusan Direktur PT Dharma Husada HAF Nomor 043/DH.HAF/I-KEP/DIR/VII/2025 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Dharma Husada dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama **Rumah Sakit Dharma Husada** yang berkedudukan di Jalan **Soekarno Hatta No 10 Kota Probolinggo** selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**. **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah rumah sakit **Swasta** dibawah naungan PT Dharma Husada HAF yang didirikan berdasarkan didirikan berdasarkan Akta nomor 05, tanggal 05 (Lima) 05 (Mei) 2025 (Dua Ribu Dua Puluh Lima), dibuat dihadapan Rita Sutandio, S.H, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Probolinggo, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya Nomor AHU-AH.01.09-0235587. Tahun 2025 tertanggal 14 (Empat Belas) 05 (Mei) 2025 (Dua Ribu Dua Puluh Lima) selaku Badan Usaha pengelola Rumah Sakit
- c. bahwa **PARA PIHAK** telah membuat perjanjian kerja sama nomor: PER/72/102025 nomor 99.1 /RSDH/E-PKS/DIR/VIII/2025 tentang Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta Program Jaminan Kecelakaan Kerja yang akan berakhir pada tanggal 1 Oktober 2025
- d. bahwa **PARA PIHAK** sepakat untuk mengakhiri perjanjian kerja sama nomor: PER/72/102025 nomor 99.1 /RSDH/E-PKS/DIR/VIII/2025 tentang Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan membuat perjanjian kerja sama yang baru untuk memberikan pelayanan kesehatan Program Jaminan Kecelakaan Kerja di **PIHAK KEDUA** bagi peserta **PIHAK PERTAMA** yang mengalami Kecelakaan Kerja atau Penyakit Akibat Kerja dan dugaan Kecelakaan Kerja atau dugaan Penyakit Akibat Kerja yang lebih optimal. **(tidak perlu dicantumkan apabila PKS telah berakhir)**
- e. bahwa **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerja sama pemberian pelayanan kesehatan Program Jaminan Kecelakaan Kerja di **PIHAK KEDUA** bagi peserta **PIHAK PERTAMA** yang mengalami Kecelakaan Kerja atau

Penyakit Akibat Kerja dan dugaan Kecelakaan Kerja atau Penyakit Akibat Kerja.
(tidak perlu dicantumkan apabila PKS masih berlaku)

Berdasarkan hal-hal di atas, **PARA PIHAK** telah sepakat dan setuju membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta Program Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disebut “Perjanjian Kerja Sama”, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1

KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

1. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau Pelayanan Kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
2. Kecelakaan Kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya, dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
3. Penyakit Akibat Kerja yang selanjutnya disingkat PAK adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan dan/atau lingkungan kerja.
4. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.
5. Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan adalah identitas sebagai bukti kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang memiliki nomor identitas tunggal yang berlaku untuk semua program jaminan sosial ketenagakerjaan yang diterbitkan oleh BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan penahapan kepesertaan.
6. Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan secara langsung kepada Peserta yang mengalami Kecelakaan Kerja dan/atau PAK dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, dan/atau rehabilitatif.
7. *Trauma Center* BPJS Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut Pusat Layanan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat PLKK adalah fasilitas Pelayanan Kesehatan berupa praktik mandiri tenaga medis atau tenaga kesehatan, pusat kesehatan masyarakat, klinik, rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan penunjang yang bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan dalam memberikan pelayanan kesehatan pada Kecelakaan Kerja dan/atau PAK.
8. Eligibilitas adalah kelayakan peserta untuk mendapatkan manfaat Pelayanan Kesehatan akibat Kecelakaan Kerja dan/atau PAK.
9. Surat Kelayakan Pelayanan yang selanjutnya disingkat SKP adalah surat yang diterbitkan oleh BPJS Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa Peserta berhak mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan manfaat program JKK.
10. Verifikasi adalah pemeriksaan tentang kebenaran administrasi klaim dan Pelayanan Kesehatan yang telah dilaksanakan oleh PLKK.

11. Aplikasi PLKK selanjutnya disebut Aplikasi e-PLKK adalah sistem informasi yang ditetapkan oleh BPJS Ketenagakerjaan untuk digunakan PLKK dalam menjalankan operasionalnya.

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai dasar pelaksanaan bagi **PARA PIHAK** dalam rangka penyediaan layanan kesehatan bagi Peserta dengan kondisi antara lain:
 - a. mengalami Kecelakaan Kerja dan/atau PAK; dan
 - b. mengalami dugaan Kecelakaan Kerja dan/atau dugaan PAK.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah terwujudnya kerja sama dan sinergi **PARA PIHAK** dalam rangka penyediaan layanan kesehatan bagi Peserta yang mengalami Kecelakaan Kerja dan/atau PAK dan yang mengalami dugaan Kecelakaan Kerja dan/atau dugaan PAK.

PASAL 3 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. pemberian Pelayanan Kesehatan bagi Peserta yang mengalami:
 1. Kecelakaan Kerja dan/atau PAK; dan
 2. dugaan Kecelakaan Kerja dan/atau dugaan PAK;
- b. tarif Pelayanan Kesehatan;
- c. tata cara pengajuan dan pembayaran tagihan biaya Pelayanan Kesehatan; dan
- d. kadaluarsa pengajuan tagihan biaya Pelayanan Kesehatan.

PASAL 4 PEMBERIAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI PESERTA

- (1) **PIHAK KEDUA** memberikan Pelayanan Kesehatan berdasarkan prosedur Pelayanan Kesehatan sesuai kebutuhan medis Peserta.
- (2) Prosedur Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Lampiran I Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 5 TARIF PELAYANAN KESEHATAN

- (1) Tarif Pelayanan Kesehatan bagi Peserta dibayarkan sesuai Tarif yang telah disepakati **PARA PIHAK**.
- (2) Tarif Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Tarif yang disepakati oleh **PARA PIHAK**, yaitu **Tarif Fee for services yang setara tarif kelas 1 Rumah Sakit Pemerintah Dr. Soetomo di Provinsi Jawa Timur**.

- (3) Tarif Pelayanan Kesehatan bagi Peserta yang mengalami dugaan Kecelakaan Kerja dan/atau dugaan PAK menggunakan tarif INA-CBGs yang telah ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Besaran Tarif Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan Lampiran II Perjanjian Kerja Sama ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini. **(rincian tarif mengikuti tarif yang disepakati pada ayat 2).**

PASAL 6

TATA CARA PENGAJUAN DAN PEMBAYARAN TAGIHAN BIAYA PELAYANAN KESEHATAN

- (1) Pengajuan tagihan biaya Pelayanan Kesehatan bulan berjalan dari **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** dilakukan 1 (satu) kali secara kolektif paling lambat tanggal 10 (sepuluh) pada bulan berikutnya dengan melengkapi dokumen persyaratan.
- (2) Dalam hal tanggal 10 (sepuluh) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur maka pengajuan tagihan dari **PIHAK KEDUA** dilakukan paling lambat pada hari kerja pertama berikutnya.
- (3) Tagihan biaya pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk tagihan biaya pelayanan kesehatan:
 - a. yang semula disimpulkan bukan Kecelakaan Kerja atau bukan PAK dan telah dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan namun ditetapkan Kecelakaan Kerja atau PAK oleh pengawas ketenagakerjaan atau Menteri Ketenagakerjaan serta telah dilakukan proses pengembalian pembayaran biaya pelayanan kesehatan oleh PLKK kepada BPJS Kesehatan; atau
 - b. yang semula disimpulkan bukan Kecelakaan Kerja atau bukan PAK namun ditetapkan Kecelakaan Kerja atau PAK oleh pengawas ketenagakerjaan atau Menteri Ketenagakerjaan.
- (4) **PIHAK PERTAMA** melakukan pengecekan kelengkapan berkas dokumen pengajuan tagihan biaya pelayanan kesehatan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak pengajuan tagihan biaya pelayanan kesehatan diterima oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (5) Dalam hal dokumen tidak lengkap, **PIHAK PERTAMA** menginformasikan dan mengembalikan berkas dokumen pengajuan tagihan biaya pelayanan kesehatan kepada **PIHAK KEDUA** untuk dilengkapi dan ditagihkan kembali pada penagihan bulan berikutnya dengan ketentuan tidak melewati kadaluarsa klaim.
- (6) Dalam hal dokumen lengkap, **PIHAK PERTAMA** menyampaikan informasi kelengkapan dokumen kepada **PIHAK KEDUA**.
- (7) **PIHAK PERTAMA** melakukan Verifikasi paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak dokumen dinyatakan lengkap dengan ketentuan:
 - a. dalam hal hasil Verifikasi **PIHAK PERTAMA** menyatakan dokumen telah sesuai dan benar maka pembayaran dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak dokumen terverifikasi dibuktikan dengan hasil verifikasi;

- b. dalam hal hasil Verifikasi menyatakan dokumen tidak sesuai dan/atau tidak benar maka **PIHAK PERTAMA** menyampaikan kepada **PIHAK KEDUA** untuk melakukan penyesuaian dokumen tagihan;
 - c. penyesuaian dokumen tagihan sebagaimana dimaksud pada huruf b disampaikan kembali oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** paling lambat 2 (dua) hari kerja;
 - d. dalam hal **PIHAK KEDUA** tidak melakukan penyesuaian dan tidak menyampaikan kembali dokumen tagihan biaya pelayanan kesehatan kepada **PIHAK PERTAMA** sesuai jangka waktu sebagaimana dimaksud huruf c maka **PIHAK PERTAMA** mengembalikan dokumen tagihan kepada **PIHAK KEDUA**; dan
 - e. dokumen tagihan biaya pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf d dapat diajukan kembali bersamaan dengan pengajuan tagihan biaya pelayanan kesehatan pada bulan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (8) Bentuk dokumen penyampaian informasi kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (9) Dalam hal batas waktu pembayaran klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a jatuh pada hari libur maka pembayaran dilakukan pada hari kerja pertama berikutnya.
- (10) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi terdapat perbedaan pengajuan tagihan, **PIHAK PERTAMA** meminta kepada **PIHAK KEDUA** untuk melakukan penyesuaian nilai kuitansi sesuai dengan nilai pembayaran yang dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (11) Tata cara pembayaran tagihan biaya Pelayanan Kesehatan secara rinci diatur dalam Lampiran III Perjanjian Kerja Sama ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 7

KADALUARSA KLAIM

- (1) Masa kadaluarsa pengajuan tagihan biaya Pelayanan Kesehatan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** paling lambat 6 (enam) bulan sejak Pelayanan Kesehatan selesai diberikan.
- (2) Masa kadaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi pengajuan tagihan sebagai berikut:
- a. biaya Pelayanan Kesehatan yang belum ditagihkan kepada **PIHAK PERTAMA**;
 - b. biaya Pelayanan Kesehatan yang telah ditagihkan kepada **PIHAK PERTAMA**, namun dokumen belum lengkap dan tidak ditagihkan kembali kepada **PIHAK PERTAMA**; dan

- c. biaya Pelayanan Kesehatan yang perlu disesuaikan berdasarkan hasil Verifikasi **PIHAK PERTAMA** dan tidak ditagihkan kembali ke **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 8

DATA

- (1) **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan penanganan kasus Kecelakaan Kerja dan/atau PAK atau dugaan Kecelakaan Kerja dan/atau dugaan PAK, menyampaikan data kepada **PIHAK PERTAMA**, berupa:
 - a. data dokter, meliputi:
 - 1) nama;
 - 2) NIK;
 - 3) nomor handphone;
 - 4) Surat Izin Praktik;
 - 5) jadwal praktik pada **PIHAK KEDUA**; dan
 - 6) detail kompetensi dokter;
 - b. sarana dan prasarana pelayanan medis **PIHAK KEDUA**;
 - c. tarif tindakan; dan
 - d. harga nett apotek obat.
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh **PIHAK KEDUA** melalui daring dan/atau luring, paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berlakunya Perjanjian Kerja Sama.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK KEDUA** wajib menyampaikan perubahan data tersebut kepada **PIHAK PERTAMA** paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya perubahan tersebut melalui surat yang disampaikan secara daring dan/atau luring.

PASAL 9

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak **PIHAK PERTAMA** adalah sebagai berikut:
 - a. mendapatkan kepastian Pelayanan Kesehatan sesuai standar Pelayanan Kesehatan yang berlaku bagi:
 - 1) Peserta yang mengalami Kecelakaan Kerja dan/atau PAK; dan
 - 2) Peserta yang mengalami dugaan Kecelakaan Kerja atau dugaan PAK sampai dengan status dugaan Kecelakaan Kerja atau dugaan PAK disimpulkan sebagai Kecelakaan Kerja/PAK atau bukan Kecelakaan Kerja atau bukan PAK.
 - b. mendapatkan data dari **PIHAK KEDUA** sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;
 - c. Peserta **PIHAK PERTAMA** yang mengalami Kecelakaan Kerja dan/atau PAK dan dugaan Kecelakaan Kerja dan/atau dugaan PAK berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dari **PIHAK KEDUA** sesuai dengan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;

- d. mendapatkan tagihan atas pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai tarif kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III Perjanjian Kerja Sama ini;
- e. Peserta yang mengalami Kecelakaan Kerja dan/atau PAK mendapatkan fasilitas rawat inap pada ruang perawatan kelas 2; **(sesuai kesepakatan)**
- f. Peserta yang mengalami dugaan Kecelakaan Kerja dan/atau dugaan PAK mendapatkan fasilitas perawatan sesuai hak kelas rawat inap Peserta pada kepesertaan Jaminan Kesehatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. mendapatkan data dan informasi dari **PIHAK KEDUA** terkait Pelayanan Kesehatan yang telah diberikan kepada Peserta, termasuk rekam medis yang dianggap perlu sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- h. mendapatkan kesimpulan dari dokter **PIHAK KEDUA** yang merawat/memeriksa Peserta atas dugaan PAK paling lambat 15 (lima belas) hari sejak laporan tahap I diterima;
- i. melakukan kredensialing kepada **PIHAK KEDUA** yang meliputi aspek legalitas, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, dan aspek lainnya sesuai dengan kebutuhan **PIHAK PERTAMA**;
- j. auditor **PIHAK PERTAMA** atau pihak eksternal yang ditunjuk **PIHAK PERTAMA** dapat melakukan audit terhadap biaya pelayanan kesehatan yang telah dibayarkan kepada **PIHAK KEDUA** atas tindak lanjut adanya kegiatan pemeriksaan di **PIHAK PERTAMA**;
- k. melakukan pemeriksaan atas Pelayanan Kesehatan yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA** untuk memastikan tindakan medis telah sesuai dengan panduan praktik klinis Peserta yang mengalami Kecelakaan Kerja dan/atau PAK;
- l. melakukan Verifikasi terhadap tagihan biaya Pelayanan Kesehatan yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA**;
- m. mendapatkan tagihan biaya Pelayanan Kesehatan dan rincian kasus Kecelakaan Kerja dan/atau PAK dari **PIHAK KEDUA** yang dilakukan 1 (satu) kali secara kolektif dari **PIHAK PERTAMA** paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya;
- n. mendapatkan kepastian pembiayaan dari **PIHAK KEDUA** untuk penempatan logo Pusat Layanan Kecelakaan Kerja;
- o. menerima pengembalian atas kelebihan pembayaran tagihan biaya Pelayanan Kesehatan dari **PIHAK KEDUA** berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh auditor internal atau eksternal yang ditunjuk **PIHAK PERTAMA** dan/atau Verifikasi pasca klaim yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK**;
- p. memberikan teguran tertulis kepada **PIHAK KEDUA** jika **PIHAK KEDUA** terlambat mengajukan tagihan biaya Pelayanan Kesehatan dan/atau melanggar/tidak melaksanakan ketentuan Perjanjian Kerja Sama; dan
- q. menerima pakta integritas terkait komitmen untuk tidak menyalahgunakan dan menjaga kerahasiaan data Peserta pada Aplikasi e-PLKK, sebagaimana bentuk pakta integritas yang tercantum dalam Lampiran IV Perjanjian Kerja Sama ini.

- (2) Kewajiban **PIHAK PERTAMA** adalah sebagai berikut:
- menyediakan Aplikasi e-PLKK untuk kemudahan pelaksanaan kerja sama;
 - melakukan sosialisasi dan edukasi kepada petugas yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA**;
 - memberikan daftar PLKK rujukan yang telah bekerja sama dengan **PIHAK PERTAMA**;
 - membuat kesimpulan atas dugaan Kecelakaan Kerja paling lambat 15 (lima belas) hari sejak laporan tahap I diterima;
 - melakukan pengecekan kelengkapan berkas dokumen tagihan biaya Pelayanan Kesehatan dan menyampaikan informasi terkait kelengkapan berkas dokumen dimaksud;
 - melakukan Verifikasi atas tagihan biaya Pelayanan Kesehatan dari **PIHAK KEDUA** paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak dokumen dinyatakan lengkap, dibuktikan dengan dokumen informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (7);
 - melakukan pembayaran atas tagihan biaya Pelayanan Kesehatan dari **PIHAK KEDUA** paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak dokumen lengkap dan benar dibuktikan dengan hasil verifikasi; dan
 - membayarkan kekurangan pembayaran kepada **PIHAK KEDUA** dalam hal terjadi kekurangan bayar berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh auditor internal atau eksternal yang ditunjuk **PIHAK PERTAMA** dan/atau Verifikasi pasca klaim oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (3) Hak **PIHAK KEDUA** adalah sebagai berikut:
- mengakses Aplikasi e-PLKK yang disediakan **PIHAK PERTAMA**;
 - mendapatkan sosialisasi dan edukasi dari **PIHAK PERTAMA** bagi petugas yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA**;
 - memperoleh daftar PLKK rujukan yang telah bekerja sama dengan **PIHAK PERTAMA**;
 - mendapatkan kesimpulan atas dugaan Kecelakaan Kerja paling lambat 15 (lima belas) hari sejak laporan tahap I diterima;
 - melakukan pengajuan tagihan biaya Pelayanan Kesehatan kepada **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini;
 - menerima pembayaran paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak dokumen tagihan biaya Pelayanan Kesehatan diterima lengkap dan dinyatakan benar berdasarkan Verifikasi oleh **PIHAK PERTAMA**;
 - meminta penjelasan kepada **PIHAK PERTAMA** perihal hasil Verifikasi dan pembayaran;
 - menerima kekurangan pembayaran tagihan biaya Pelayanan Kesehatan dari **PIHAK PERTAMA** dalam hal terjadi kekurangan bayar berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh auditor internal atau eksternal yang ditunjuk **PIHAK PERTAMA** dan/atau Verifikasi pasca klaim oleh **PIHAK PERTAMA**;
 - memberikan teguran tertulis kepada **PIHAK PERTAMA** atas keterlambatan pembayaran tagihan biaya Pelayanan Kesehatan; dan
 - mendapatkan informasi hasil Verifikasi.
- (4) Kewajiban **PIHAK KEDUA** adalah sebagai berikut:

- a. memberikan Pelayanan Kesehatan kepada Peserta sesuai standar Pelayanan Kesehatan yang berlaku bagi:
 - 1) Peserta yang mengalami Kecelakaan Kerja dan/atau PAK; dan
 - 2) Peserta yang mengalami dugaan Kecelakaan Kerja atau dugaan PAK sampai dengan status dugaan Kecelakaan Kerja atau dugaan PAK disimpulkan sebagai Kecelakaan Kerja/PAK atau bukan Kecelakaan Kerja atau bukan PAK,
- b. menyampaikan data kepada **PIHAK PERTAMA** sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;
- c. **PIHAK KEDUA** memberikan pelayanan kesehatan kepada Peserta yang mengalami Kecelakaan Kerja dan/atau PAK dan dugaan Kecelakaan Kerja dan/atau dugaan PAK sesuai dengan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;
- d. menyampaikan tagihan atas pelayanan kesehatan yang dilakukan kepada **PIHAK PERTAMA** sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III Perjanjian Kerja Sama ini;
- e. menyediakan fasilitas rawat inap pada ruang perawatan kelas 2 (**sesuai kesepakatan**) bagi peserta **PIHAK PERTAMA** yang mengalami Kecelakaan Kerja dan/atau PAK;
- f. menyediakan fasilitas perawatan sesuai hak kelas rawat inap Peserta yang mengalami dugaan Kecelakaan Kerja dan/atau dugaan PAK pada kepesertaan Jaminan Kesehatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. mengajukan tagihan biaya Pelayanan Kesehatan dan memberikan laporan rincian kasus Kecelakaan Kerja dan/atau PAK yang dilakukan 1 (satu) kali secara kolektif kepada **PIHAK PERTAMA** paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya;
- h. menyediakan data dan informasi untuk **PIHAK PERTAMA** terkait Pelayanan Kesehatan yang telah diberikan kepada Peserta, termasuk rekam medis yang dianggap perlu sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- i. menyediakan data dan informasi kepada **PIHAK PERTAMA** terkait aspek legalitas, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, dan aspek lainnya sesuai dengan kebutuhan **PIHAK PERTAMA**;
- j. menyampaikan kesimpulan dari dokter **PIHAK KEDUA** yang merawat/memeriksa Peserta atas dugaan PAK paling lambat 15 (lima belas) hari sejak laporan tahap I diterima;
- k. mengembalikan kelebihan pembayaran tagihan biaya Pelayanan Kesehatan berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh auditor internal atau eksternal yang ditunjuk **PIHAK PERTAMA** dan/atau Verifikasi pasca klaim oleh **PIHAK PERTAMA**;
- l. menyampaikan informasi kepada **PIHAK PERTAMA** perihal Kecelakaan Kerja dan/atau PAK Peserta yang sedang dilakukan perawatan oleh **PIHAK KEDUA**;
- m. menggunakan Aplikasi e-PLKK yang disediakan oleh **PIHAK PERTAMA**;

- n. memberikan pakta integritas terkait komitmen untuk tidak menyalahgunakan dan menjaga kerahasiaan data Peserta pada Aplikasi e-PLKK, sebagaimana bentuk pakta integritas yang tercantum dalam Lampiran IV Perjanjian Kerja Sama ini dan memberitahukan secara tertulis apabila terdapat pergantian *user* **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA**;
- o. melakukan pemasangan logo PLKK dan media informasi terkait **PIHAK PERTAMA** di tempat strategis;
- p. menanggung biaya yang timbul atas penempatan logo Pusat Layanan Kecelakaan Kerja pada **PIHAK KEDUA**;
- q. mengganti kerugian yang timbul atas terjadinya kecurangan yang disebabkan oleh **PIHAK KEDUA** atau petugas yang ditunjuk **PIHAK KEDUA**;
- r. menyediakan sistem antrian, jadwal tindakan medis operatif dan informasi ketersediaan ruang perawatan rawat inap biasa dan ruang perawatan ICU yang dapat diakses oleh Peserta dan **PIHAK PERTAMA**;
- s. menyediakan informasi isi rekam medis yang paling sedikit terdiri atas identitas pasien, hasil pemeriksaan fisik dan penunjang, diagnosis, pengobatan dan rencana tindak lanjut Pelayanan Kesehatan, nama dan tanda tangan tenaga kesehatan pemberi Pelayanan Kesehatan. Dalam hal dibutuhkan untuk menindaklanjuti hasil audit dan/atau verifikasi paska klaim, **PIHAK KEDUA** mengizinkan untuk melihat rekam medis sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
- t. menginformasikan secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA** dalam hal terdapat perubahan dokumen yang menjadi persyaratan mutlak kerja sama (Izin Operasional/Izin Usaha, Surat Izin Praktik, Sertifikat Akreditasi) selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterbitkannya dokumen perubahan atau sejak diterimanya dokumen perubahan tersebut oleh **PIHAK KEDUA**.

PASAL 10

PEMBERITAHUAN DUGAAN

- (1) **PIHAK KEDUA** berhak menyampaikan pemberitahuan dugaan Kecelakaan Kerja dan/atau dugaan PAK yang dialami oleh Peserta kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Pemberitahuan dugaan Kecelakaan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:
 - a. nomor kepesertaan/nomor induk kependudukan;
 - b. kronologi kejadian, termasuk tempat, sumber penyebab, tanggal dan jam kejadian Kecelakaan Kerja; dan
 - c. nama dan nomor telepon pihak yang memberitahukan dan/atau pihak yang dapat dihubungi.
- (3) Pemberitahuan dugaan PAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:
 - a. nomor kepesertaan/nomor induk kependudukan;

- b. nama dan nomor telepon pihak yang memberitahukan dan/atau pihak yang dapat dihubungi;
- c. jenis pekerjaan;
- d. masa kerja dan masa kerja pada pekerjaan terakhir;
- e. sumber pajanan; dan
- f. diagnosis klinis.

PASAL 11

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak tanggal ... sampai dengan tanggal ... **(maksimal jangka waktu 1 (satu) tahun)**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum dilakukan perubahan atau berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 12

KERAHASIAAN DAN KEAMANAN

- (1) Seluruh informasi dan data dalam bentuk apapun yang terkait dengan Perjanjian Kerja Sama ini bersifat rahasia dan merupakan kewajiban **PARA PIHAK** untuk menjaga kerahasiaannya, kecuali:
 - a. telah disetujui secara tertulis oleh **PIHAK** pemberi informasi;
 - b. informasi dan data tersebut sudah merupakan informasi milik umum, karena sudah dibuka kepada umum oleh pihak pemilik informasi;
 - c. harus diberikan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan wajib segera diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya; dan
 - d. berdasarkan penetapan pengadilan.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat untuk tidak memanfaatkan informasi dan data yang diperoleh dari masing-masing pihak dalam bentuk apapun dan untuk keperluan apapun kecuali yang berkaitan dengan maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan-ketentuan tentang kerahasiaan tetap berlaku meskipun Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau putus karena sebab apapun juga serta tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi **PARA PIHAK**.

PASAL 13

PERNYATAAN ANTI KORUPSI, PENYUAPAN DAN MONEY LAUNDERING

- (1) Demi terjaganya kondusifitas selama bekerja sama serta mendukung penerapan sistem Manajemen Anti Penyusapan sesuai dengan ISO 37001:2016, maka dengan ini **PARA PIHAK** menyatakan sebagai berikut:

- a. tidak akan melakukan praktik korupsi, kolusi, nepotisme dan *money laundering*;
 - b. tidak akan memberikan sesuatu yang dapat dikategorikan sebagai suap dan/atau gratifikasi baik dalam proses maupun setelah diberlakukannya kerja sama; dan
 - c. menjamin proses kerja sama yang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak ada unsur kepentingan pada masing-masing pihak di dalamnya.
- (2) Pernyataan **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini akan tetap berlaku walaupun Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.
- (3) Dalam hal salah satu Pihak melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pihak lainnya berhak melakukan pemutusan Perjanjian Kerja Sama ini secara sepihak.

PASAL 14 **PEMBERITAHUAN**

PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan surat menyurat atau pemberitahuan yang perlu dilakukan oleh salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini, sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 15 **SANKSI**

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberikan teguran tertulis kepada **PIHAK KEDUA** apabila melakukan pelanggaran sebagai berikut:
- a. tidak melaksanakan ketentuan Perjanjian Kerja Sama;
 - b. terlambat melakukan pengajuan tagihan biaya Pelayanan Kesehatan lebih dari 1 (satu) bulan;
 - c. **PIHAK KEDUA** terbukti melakukan pelanggaran ketentuan kerahasiaan pada Perjanjian Kerja Sama ini;
 - d. petugas **PIHAK KEDUA** atau **PIHAK KEDUA** melakukan tindakan yang merusak citra **PIHAK PERTAMA**;
 - e. memungut biaya tambahan kepada Peserta diluar ketentuan; dan/atau
 - f. **PIHAK KEDUA** tidak menyampaikan kesimpulan dugaan PAK kepada **PIHAK PERTAMA** sampai dengan batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf j;
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan mekanisme sebagai berikut:
- a. dalam hal **PIHAK KEDUA**:
 - 1) melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e maka **PIHAK PERTAMA** memberikan teguran dengan mengirimkan surat peringatan pertama paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui adanya pelanggaran oleh **PIHAK KEDUA**; atau

- 2) melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f maka **PIHAK PERTAMA** memberikan teguran dengan mengirimkan surat peringatan pertama paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak diketahui adanya pelanggaran oleh **PIHAK KEDUA**.
- b. apabila surat peringatan pertama telah diterima oleh **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA**:
 - 1) tidak memberikan tanggapan dan tidak ada perbaikan untuk pelanggaran yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak surat peringatan pertama diterima oleh **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK PERTAMA** memberikan teguran dengan mengirimkan surat peringatan kedua; atau
 - 2) tidak menyampaikan kesimpulan dugaan PAK sampai dengan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diagnosa klinis dugaan PAK telah disampaikan kepada **PIHAK PERTAMA**, maka seluruh biaya Pelayanan Kesehatan atas dugaan PAK Peserta menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.
- c. apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak surat peringatan kedua diterima oleh **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 1) dan **PIHAK KEDUA** tidak memberikan tanggapan dan tidak ada perbaikan maka **PIHAK PERTAMA** menindaklanjuti dengan pemutusan Perjanjian Kerja Sama dan meminta penggantian terhadap kerugian yang ditimbulkan oleh **PIHAK KEDUA** apabila ada.
- (3) Dalam hal **PIHAK KEDUA** atau petugas yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA** terbukti melakukan kecurangan yang merugikan **PIHAK PERTAMA** maka **PIHAK PERTAMA** menindaklanjuti dengan pemutusan Perjanjian Kerja Sama dan meminta penggantian terhadap kerugian yang ditimbulkan oleh **PIHAK KEDUA** apabila ada.
- (4) Dalam hal **PIHAK PERTAMA** terlambat melakukan pembayaran tagihan biaya Pelayanan Kesehatan yang telah dinyatakan lengkap dan benar oleh **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, maka **PIHAK KEDUA** memberikan teguran dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. **PIHAK KEDUA** mengirimkan surat peringatan pertama kepada **PIHAK PERTAMA** paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak batas waktu pembayaran yang telah ditentukan;
 - b. jika dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak surat peringatan pertama diterima oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK PERTAMA** masih belum melakukan pembayaran maka **PIHAK KEDUA** mengirimkan surat peringatan kedua;
 - c. jika dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak surat peringatan kedua diterima oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK PERTAMA** belum melakukan pembayaran tagihan, maka **PIHAK KEDUA** mengirimkan surat pemberitahuan penghentian sementara pemberian Pelayanan Kesehatan kepada Peserta **PIHAK PERTAMA**; dan

- d. **PIHAK KEDUA** kembali memberikan Pelayanan Kesehatan setelah **PIHAK PERTAMA** melunasi tagihan biaya Pelayanan Kesehatan yang telah dinyatakan lengkap dan benar oleh **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 16

MONITORING DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling lama setiap 6 (enam) bulan.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. persyaratan administratif dan operasional sebagai Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
 - b. kepatuhan program jaminan sosial ketenagakerjaan;
 - c. sarana dan prasarana; dan
 - d. kualitas pelayanan.

PASAL 17

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (selanjutnya disebut *Force Majeure*) adalah suatu keadaan yang terjadinya di luar kemampuan, kesalahan, atau kekuasaan **PARA PIHAK** dan yang menyebabkan Pihak yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam Perjanjian Kerja Sama ini. *Force Majeure* tersebut meliputi banjir, wabah, perang (yang dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan), pemberontakan, huru-hara, pemogokan umum, kebakaran dan kebijakan Pemerintah berdasarkan surat pemberitahuan dari pemerintah daerah, pemerintah pusat atau pihak yang berwenang yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Dalam hal terjadinya peristiwa *Force Majeure*, maka **PIHAK** yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh **PIHAK** lainnya. **PIHAK** yang terkena *Force Majeure* wajib memberitahukan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut kepada **PIHAK** yang lain secara tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari sejak saat terjadinya peristiwa *Force Majeure*, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut. **PIHAK** yang terkena *Force Majeure* wajib mengupayakan dengan sebaik-baiknya untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini segera setelah peristiwa *Force Majeure* berakhir.
- (3) Apabila peristiwa *Force Majeure* tersebut berlangsung terus hingga melebihi atau diduga oleh Pihak yang mengalami *Force Majeure* akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini.

- (4) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu Pihak sebagai akibat terjadinya peristiwa *Force Majeure* bukan merupakan tanggung jawab pihak yang lain.

PASAL 18

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Apabila terdapat hal-hal yang belum diatur atau perlu dilakukan perubahan substansi dalam Perjanjian Kerja Sama ini, maka akan dilakukan perubahan atau tambahan (adendum) dengan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suatu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 19

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan permasalahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, penyelesaian perselisihan akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai maka **PARA PIHAK** setuju untuk menyelesaikan melalui Pengadilan Negeri **Kota Pasuruan**.

PASAL 20

PENGAKHIRAN PERJANJIAN KERJA SAMA

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir karena hal-hal sebagai berikut:
- a. jangka waktu Perjanjian Kerja Sama berakhir;
 - b. dikehendaki oleh salah satu Pihak dan disetujui Pihak lainnya; atau
 - c. pengakhiran sepihak oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Terhadap pengakhiran Perjanjian Kerja Sama yang dikehendaki oleh salah satu **PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. **PIHAK** yang menginginkan pengakhiran wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum tanggal pengakhiran dikehendaki;
 - b. **PIHAK** yang menerima permintaan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama wajib memberikan jawaban terhadap pengajuan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak pengajuan tertulis diterima; dan
 - c. dalam hal **PIHAK** yang menerima permintaan pengakhiran tidak memberikan jawaban dalam waktu sebagaimana dimaksud pada huruf b, permintaan pengakhiran dianggap disetujui.
- (3) Pengakhiran Perjanjian sepihak oleh **PIHAK PERTAMA** dilakukan atas kehendak **PIHAK PERTAMA** dalam hal:

- a. **PIHAK KEDUA** melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan telah mendapat surat peringatan sebanyak 2 (dua) kali dari **PIHAK PERTAMA** namun tidak ada tanggapan dan tidak ada perbaikan;
 - b. **PIHAK KEDUA** melakukan kecurangan;
 - c. **PIHAK KEDUA** melakukan malpraktik;
 - d. **PIHAK KEDUA** tidak memenuhi standar kredensialing yang ditetapkan **PIHAK PERTAMA**;
 - e. **PIHAK KEDUA** terbukti melanggar pernyataan anti korupsi, penyuapan, dan *money laundering*; dan/atau
 - f. **PIHAK KEDUA** berada dalam keadaan pailit berdasarkan putusan pengadilan.
- (4) Pengakhiran Perjanjian ini mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

PASAL 21 PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) rangkap diantaranya bermeterai cukup dan berlaku sebagai asli serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing pihak mendapat 1 (satu) rangkap sedangkan 2 (dua) rangkap lainnya sebagai *copy* untuk keperluan administrasi.

PIHAK KEDUA
RS DHARMA HUSADA PROBOLINGGO

PIHAK PERTAMA
BPJS KETENAGAKERJAAN
KANTOR CABANG PASURUAN

dr. IFIT BAGUS APRIANTONO, M.MRS
DIREKTUR

SULISTIJO NISITA WIRJAWAN
KEPALA KANTOR CABANG

LAMPIRAN I
PERJANJIAN KERJA SAMA
TENTANG
PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN
BAGI PESERTA PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA

Nomor: PER/ ... /.... (nomor PIHAK PERTAMA)

Nomor: (nomor PIHAK KEDUA)

PROSEDUR PELAYANAN KESEHATAN

I. PELAYANAN MEDIS

1. Pelayanan medis kepada peserta **PIHAK PERTAMA** yang mengalami Kecelakaan Kerja dan/atau PAK diberikan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai ketentuan perundang-undangan dengan **Tarif Fee for services yang setara tarif kelas 1 Rumah Sakit Pemerintah Dr. Soetomo di Provinsi Jawa Timur**.
2. Pelayanan medis kepada peserta **PIHAK PERTAMA** yang mengalami dugaan Kecelakaan Kerja dan/atau dugaan PAK diberikan oleh **PIHAK KEDUA** dengan tarif INA-CBGs yang telah ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. **PIHAK KEDUA** wajib menyediakan ruang perawatan kelas 2, (bagi rumah sakit pemerintah kelas 1 dan bagi rumah sakit swasta setara rumah sakit pemerintah kelas 1 provinsi setempat sebagaimana pasal 5 ayat 2) untuk Peserta yang mengalami Kecelakaan Kerja dan/atau PAK dan apabila tidak tersedia kelas yang ditentukan maka Peserta dilayani di ruang perawatan 1 (satu) tingkat lebih tinggi sampai dengan ruang perawatan kelas yang seharusnya tersedia kembali. Penagihan biaya ruang perawatan yang lebih tinggi ditagihkan berdasarkan tarif kelas perawatan yang telah disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama dan selisih biaya yang timbul akibat tidak tersedia kelas yang disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama ini menjadi beban **PIHAK KEDUA** dan tidak dapat ditagihkan kepada **PIHAK PERTAMA**, Peserta, keluarga Peserta, Pemberi Kerja dan/atau Pejabat Pembina Kepegawaian.
4. **PIHAK KEDUA** wajib menyediakan ruang perawatan sesuai hak kelas rawat inap Peserta pada kepesertaan Jaminan Kesehatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan untuk Peserta yang mengalami dugaan Kecelakaan Kerja dan/atau PAK dan apabila tidak tersedia kelas yang ditentukan maka Peserta dilayani di ruang perawatan 1 (satu) tingkat lebih tinggi sampai dengan ruang perawatan kelas yang seharusnya tersedia kembali. Selisih biaya yang timbul akibat tidak tersedia kelas yang disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama ini menjadi beban **PIHAK KEDUA** dan tidak dapat ditagihkan kepada **PIHAK PERTAMA**, Peserta, keluarga Peserta, Pemberi Kerja dan/atau Pejabat Pembina Kepegawaian.

5. Dalam hal kelas ruang perawatan sebagaimana angka 3 (tiga) dan 4 (empat) belum tersedia lebih dari 7 (tujuh) hari sejak Peserta di rawat inap maka Peserta diberikan pilihan:
 - a. dirawat 1 (satu) kelas lebih rendah; atau
 - a. dirujuk ke PLKK lain.
6. Penagihan biaya ruang perawatan yang lebih rendah sesuai dengan angka 5 (lima) huruf a ditagihkan sesuai ruang kelas perawatan yang digunakan oleh Peserta.
7. Dalam hal Peserta, Pemberi Kerja dan/atau Pejabat Pembina Kepegawaian menginginkan kelas perawatan lebih tinggi dari kelas yang telah ditentukan maka Peserta/keluarga Peserta, Pemberi Kerja dan/atau Pejabat Pembina Kepegawaian harus menandatangani surat pernyataan dari Rumah Sakit dan selisih biaya menjadi tanggung jawab Peserta/keluarga Peserta, Pemberi Kerja dan/atau Pejabat Pembina Kepegawaian.
8. Lama hari rawat inap dihitung dari selisih antara tanggal pulang/tanggal keluar rumah sakit (kondisi hidup atau meninggal dunia) dengan tanggal masuk rumah sakit.
9. Dalam hal Peserta diberikan Pelayanan Kesehatan di ruang rawat inap yang masuk dan keluar pada hari yang sama maka dihitung 1 (satu) hari.

II. ALUR PELAYANAN

PIHAK KEDUA memberikan Pelayanan Kesehatan kepada Peserta Program JKK dan/atau Program JKN yang mengalami Kecelakaan Kerja dan/atau PAK, dugaan Kecelakaan Kerja dan/atau dugaan PAK melalui prosedur pelayanan sebagai berikut:

1. Pasien datang berobat pada **PIHAK KEDUA** dan Petugas **PIHAK KEDUA** melakukan identifikasi serta pemeriksaan untuk menentukan apakah Pasien memenuhi kriteria:
 - a. Kasus Kecelakaan Kerja;
 - b. PAK;
 - c. Dugaan Kecelakaan Kerja; dan
 - d. Dugaan PAK,
2. Dalam hal Pasien sebagaimana angka 1 (satu) memenuhi salah satu kriteria, maka Petugas **PIHAK KEDUA** meneliti Eligibilitas:
 - a. Bagi Peserta PU dan BPU melalui Aplikasi e-PLKK berdasarkan NIK atau Nomor Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan di *website* BPJS Ketenagakerjaan (alamat *website*: <https://e-plkk.bpjsketenagakerjaan.go.id/login.bpjs>) dan/atau kemudian menghubungi petugas **PIHAK PERTAMA** untuk melakukan konfirmasi apabila diperlukan; atau
 - b. Bagi Peserta Jasa Konstruksi dan Pekerja Migran Indonesia melalui konfirmasi kepada petugas **PIHAK PERTAMA**,
3. Dalam hal Peserta memenuhi kriteria sebagaimana pada angka 1 (satu) huruf a, huruf b, atau huruf c dan eligibilitas Kepesertaan, maka:
 - a. untuk Peserta PU dan BPU, petugas **PIHAK KEDUA** mengisi uraian Kecelakaan Kerja/PAK/dugaan KK di *website* BPJS Ketenagakerjaan

- (alamat [website: https://e-plkk.bpjsketenagakerjaan.go.id/form/tahap1.bpjs](https://e-plkk.bpjsketenagakerjaan.go.id/form/tahap1.bpjs)) sebagai pemberitahuan Kecelakaan Kerja/PAK/dugaan KK kepada Peserta, Pemberi Kerja, Pejabat Pembina Kepegawaian dan/atau Keluarga melalui daring/luring;
- b. untuk Peserta Jasa Konstruksi dan Pekerja Migran Indonesia, petugas **PIHAK KEDUA** menyampaikan kepada Peserta/Pemberi Kerja/Perusahaan Jasa Konstruksi agar menyampaikan laporan tahap 1 KK/PAK; atau
 - c. untuk Pekerja Migran Indonesia dikecualikan untuk kriteria sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c dan huruf d,
4. Dalam hal Peserta memenuhi kriteria sebagaimana pada angka 1 (satu) huruf d dan eligibilitas Kepesertaan, maka petugas **PIHAK KEDUA** mengarahkan Peserta diperiksa oleh Dokter **PIHAK KEDUA** untuk memperoleh Diagnosa Klinis dugaan PAK melalui formulir diagnosa klinis PAK;
 5. Dalam hal dokter **PIHAK KEDUA**:
 - a. menyatakan bahwa Peserta memperoleh diagnosa klinis dugaan PAK sebagaimana dimaksud pada angka 4, maka:
 1. untuk Peserta PU dan BPU, petugas **PIHAK KEDUA** mengisi uraian dugaan PAK di *website* BPJS Ketenagakerjaan (alamat *website*: <https://e-plkk.bpjsketenagakerjaan.go.id/form/tahap1.bpjs>) dan mengupload dokumen formulir diagnosa klinis PAK yang diisi oleh dokter **PIHAK KEDUA** sebagai pemberitahuan dugaan PAK kepada Peserta, Pemberi Kerja, Keluarga dan/atau Pejabat Pembina Kepegawaian melalui daring/luring; atau
 2. untuk Peserta Jasa Konstruksi, petugas **PIHAK KEDUA** menyampaikan kepada Peserta/Pemberi Kerja/Perusahaan Jasa Konstruksi agar menyampaikan laporan tahap 1 KK/PAK,
 - b. menyatakan bahwa Peserta tidak memperoleh diagnosa klinis dugaan PAK, maka:
 1. untuk Peserta PU, BPU, Jasa Konstruksi atau Pekerja Migran Indonesia yang memiliki rujukan dari fasilitas Pelayanan Kesehatan pertama melalui mekanisme JKN, maka Peserta akan dilayani melalui penjaminan Program JKN; atau
 2. untuk Peserta PU, BPU, Jasa Konstruksi yang tidak memiliki rujukan dan bukan kasus gawat darurat, Peserta dapat menggunakan asuransi lain atau pembiayaan lainnya diluar mekanisme yang ada di **PARA PIHAK** dan Peserta tidak dijamin dalam koordinasi penjaminan dugaan PAK,
 6. Peserta, Pemberi Kerja, Pejabat Pembina Kepegawaian dan/atau Keluarga menindaklanjuti pemberitahuan dari petugas **PIHAK KEDUA** dengan menyampaikan laporan tahap I;

7. Dalam hal penyampaian laporan tahap I dilakukan oleh Peserta, Pemberi Kerja, Pejabat Pembina Kepegawaian dan/atau Keluarga melalui **PIHAK KEDUA**, **PIHAK KEDUA** memastikan hal-hal sebagai berikut:
 - 7.1. Untuk Peserta Penerima Upah, Pemberi Kerja atau Pejabat Pembina Kepegawaian menyampaikan laporan tahap I kepada **PIHAK PERTAMA** melalui **PIHAK KEDUA** dengan sarana:
 - a. bagi Pemberi Kerja atau Pejabat Pembina Kepegawaian merupakan pengguna Sistem Informasi Pelaporan Perusahaan (SIPP) maka Pemberi Kerja atau Pejabat Pembina Kepegawaian mengisi e-formulir KK tahap I (Form 3 KK 1) atau e-formulir Penyakit Akibat Kerja tahap I (Form 3 PAK 1) pada SIPP dan dilengkapi dengan dokumen pendukung pengajuan tahap I; atau
 - b. bagi Pemberi Kerja atau Pejabat Pembina Kepegawaian bukan merupakan pengguna Sistem Informasi Pelaporan Perusahaan (SIPP) maka Pemberi Kerja atau Pejabat Pembina Kepegawaian mengisi dan menyerahkan formulir KK tahap I (Form 3 KK 1) atau formulir Penyakit Akibat Kerja tahap I (Form 3 PAK 1) pada SIPP dan dilengkapi dengan dokumen pendukung pengajuan tahap I,
 - 7.2. Untuk Peserta Bukan Penerima Upah, Peserta/pihak keluarga mengisi dan menyerahkan formulir KK tahap I (Form 3 KK 1) atau formulir Penyakit Akibat Kerja tahap I (Form 3 PAK 1) pada SIPP dan dilengkapi dengan dokumen pendukung pengajuan tahap I; dan
 - 7.3. Untuk Peserta Jasa Konstruksi atau Pekerja Migran Indonesia maka, Pemberi Kerja/Pejabat Pembina Kepegawaian/Perusahaan Jasa Konstruksi atau Pekerja Migran Indonesia/Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia mengisi dan menyerahkan formulir KK tahap I (Form 3 KK 1) atau formulir Penyakit Akibat Kerja tahap I (Form 3 PAK 1) pada SIPP dan dilengkapi dengan dokumen pendukung pengajuan tahap I,
8. **PIHAK KEDUA** menyampaikan pengajuan SKP kepada **PIHAK PERTAMA** dengan melampirkan laporan tahap I beserta dokumen pendukung;
9. **PIHAK KEDUA** memastikan Pemberi Kerja/Pejabat Pembina Kepegawaian/Peserta/keluarga/Perusahaan Jasa Konstruksi/Pekerja Migran Indonesia/Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia mengisi dan menyerahkan surat pernyataan bersedia menanggung biaya perawatan dan pengobatan yang tidak ditanggung oleh **PIHAK PERTAMA** sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
10. **PIHAK PERTAMA** melakukan Verifikasi/pemeriksaan terhadap permohonan pengajuan SKP dari **PIHAK KEDUA** dan menerbitkan SKP paling lambat 2 (dua) hari kerja melalui website e-PLKK (<https://e-plkk.bpjsketenagakerjaan.go.id/>);
11. **PIHAK KEDUA** memberikan Pelayanan Kesehatan sesuai indikasi medis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam hal Peserta memerlukan tindakan operatif/pemeriksaan khusus maka petugas **PIHAK KEDUA** wajib melakukan konfirmasi kepada Petugas **PIHAK PERTAMA**;

12. Dokter **PIHAK KEDUA** yang merawat Peserta wajib mengisi formulir 3b KK 3 untuk kasus Kecelakaan Kerja atau formulir 3b PAK 3 untuk kasus Penyakit Akibat Kerja jika perawatan dan pengobatan dinyatakan selesai dengan status kondisi akhir sembuh, cacat, atau meninggal dunia;
13. **PIHAK KEDUA** dapat memberikan jasa pengangkutan berupa pelayanan ambulans untuk menjemput dan/atau mengantar Peserta yang mengalami Kecelakaan Kerja atau PAK di lokasi kerja ke rumah sakit dan /atau ke rumahnya, pertolongan pertama pada Kecelakaan Kerja/PAK, dan rujukan ke rumah sakit lain; dan
14. Penggantian biaya pelayanan ambulans sesuai dengan tarif kesepakatan dalam Perjanjian Kerja Sama.

III. PELAYANAN OBAT DAN ALAT KESEHATAN

1. Pemberian resep obat-obatan oleh dokter yang memeriksa atau dokter yang menangani di **PIHAK KEDUA** bagi Peserta Program JKK mengutamakan obat Generik dan Formularium Nasional.
2. Harga obat dan alat kesehatan menggunakan patokan Harga Netto Apotik ditambah PPN dan biaya pelayanan kefarmasian 30% dari harga tersebut.
3. Harga Netto Apotik sebagaimana dimaksud pada angka 2, mengacu pada tarif yang disepakati saat ditandatanganinya Berita Acara Negosiasi Tarif sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II Perjanjian Kerja Sama ini.
4. Untuk harga obat dan alat kesehatan lebih dari Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) menggunakan patokan harga netto ditambah PPN dengan biaya pelayanan kefarmasian 20%.

IV. RUJUKAN

Dalam hal Peserta memerlukan penanganan di PLKK yang lebih lengkap dan/atau alasan lain dengan persetujuan dokter yang merawat, **PIHAK KEDUA** dapat merujuk Peserta ke PLKK lainnya dengan melaksanakan prosedur sebagai berikut:

1. Peserta mendapatkan persetujuan untuk dirujuk ke PLKK lain dari dokter yang merawat;
2. **PIHAK KEDUA** melakukan penginputan e-formulir rujukan dalam Aplikasi e-PLKK dan memilih PLKK tujuan rujukan bagi Peserta PU dan BPU. Bagi Peserta Jasa Konstruksi dan Peserta Pekerja Migran Indonesia mengisi dan mengirimkan formulir rujukan secara manual kepada **PIHAK PERTAMA**;
3. **PIHAK KEDUA** menginformasikan adanya rujukan kepada **PIHAK PERTAMA** untuk Peserta Jasa Konstruksi dan Peserta Pekerja Migran Indonesia;
4. **PIHAK PERTAMA** melakukan pemeriksaan e-formulir/formulir rujukan dan berkoordinasi dengan Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan yang bekerja sama dengan PLKK rujukan;
5. Dalam hal Peserta layak dirujuk ke PLKK lain, **PIHAK PERTAMA** melakukan persetujuan rujukan dan mengirimkan pemberitahuan ke PLKK tujuan rujukan; dan

6. Dalam hal PLKK rujukan menerima Peserta, PLKK penerima rujukan memberikan Pelayanan Kesehatan sesuai dengan indikasi medis Peserta.

V. KATEGORI PELAYANAN KESEHATAN

Pelayanan Kesehatan sesuai kebutuhan medis program JKK yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA** kepada Peserta program JKK meliputi:

1. Pemeriksaan dasar dan penunjang;
2. Perawatan tingkat pertama dan Perawatan lanjutan;
3. Rawat inap;
4. Penunjang diagnostik
5. Penanganan, termasuk komorbiditas dan komplikasi yang berhubungan dengan Kecelakaan kerja dan PAK;
6. Perawatan intensif;
7. Pelayanan khusus;
8. Alat kesehatan dan implan;
9. Jasa dokter/medis;
10. Operasi;
11. Pelayanan darah;
12. Rehabilitasi medik;
13. Perawatan dirumah bagi Peserta yang tidak memungkinkan melanjutkan pengobatan ke rumah sakit; dan/atau
14. Pemeriksaan diagnostik dalam penyelesaian kasus PAK.

VI. PERAWATAN DI RUMAH (*HOME CARE*) * (*apabila PIHAK KEDUA memiliki fasilitas home care, apabila tidak ada angka VI ini dihapus*)

1. Manfaat *Home Care* diberikan kepada Peserta dengan persyaratan sebagai berikut:
 - 1.1. Peserta yang mengalami Kecelakaan Kerja atau PAK yang tidak memungkinkan melanjutkan pengobatan ke rumah sakit karena keterbatasan fisik dan/atau kondisi geografis;
 - 1.2. adanya rekomendasi dokter pemeriksa dari **PIHAK KEDUA** dan/atau dokter penasihat; dan
 - 1.3. adanya persetujuan dari **PIHAK PERTAMA**,
2. *Home Care* untuk Peserta dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**;
3. Manfaat *Home Care* meliputi tindakan medis dan asuhan keperawatan sesuai standar *Home Care*;
4. Tindakan medis dan asuhan keperawatan sebagai berikut:
 - 4.1. perawatan luka seperti *debridement* atau irigasi luka, pembalutan luka, pengkajian dan pengambilan kultur luka, monitoring perkembangan penyembuhan luka, dan mengajarkan keluarga tentang perawatan luka di rumah;
 - 4.2. perawatan pasien dengan gangguan sistem pernapasan seperti pengisapan atau *suction* lendir, manajemen terapi oksigen, manajemen ventilasi mekanik, dan perawatan *tracheostomy*;
 - 4.3. perawatan pasien dengan gangguan eliminasi seperti irigasi dan perawatan kolostomi, mengajarkan pasien dan keluarganya tentang

- cara menggunakan peralatan seperti pispot, urinal, perawatan kateter urin, dan observasi adanya tanda-tanda infeksi;
- 4.4. perawatan pasien dengan gangguan nutrisi seperti memberi makan melalui NGT, mengajarkan keluarga tentang cara memberikan makanan, mengkaji status nutrisi pasien, dan memberikan petunjuk pelaksanaan diet;
 - 4.5. kegiatan rehabilitasi seperti mengajarkan keluarga tentang cara menggunakan alat bantu, melakukan latihan fisik, ambulasi dan teknik pemindahan pasien;
 - 4.6. pelaksanaan pengobatan seperti memberi petunjuk dan membimbing pasien dan keluarganya tentang cara pemberian obat, cara kerja dan efek samping obat serta tindakan yang harus dilakukan; dan
 - 4.7. kolaborasi pemberian terapi intravena seperti pengkajian dan penatalaksanaan hidrasi, pemberian antibiotik, pemberian nutrisi parenteral, transfusi darah, pemberian analgetik dan chemoterapi,
5. Diberikan kepada Peserta paling lama 1 (satu) tahun sejak direkomendasikan oleh dokter pemeriksa/dokter yang merawat dan disetujui **PIHAK PERTAMA** untuk dilakukan *Home Care* dengan biaya paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), tidak termasuk biaya obat-obatan dan alat kesehatan;
 6. Pembiayaan atas obat-obatan dan alat kesehatan yang timbul untuk *Home Care* dimasukkan ke dalam tagihan biaya Pelayanan Kesehatan melalui **PIHAK KEDUA**, sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati; dan
 7. Dalam hal perawatan dan pengobatan telah mencapai masa 1 (satu) tahun atau pembiayaan telah mencapai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) maka perawatan dan pengobatan lanjutan dilakukan di **PIHAK KEDUA**.

VII. KOMORBIDITAS DAN KOMPLIKASI

1. Komorbiditas dan komplikasi yang dapat ditanggung merupakan komorbiditas dan komplikasi yang berhubungan dengan Kecelakaan Kerja atau PAK;
2. Komorbiditas/penyakit penyerta yang diderita oleh Peserta sebelum terjadi Kecelakaan Kerja atau PAK dapat ditanggung **PIHAK PERTAMA** saat Peserta menjalani perawatan pertama di **PIHAK KEDUA**;
3. Peserta yang mengalami komorbiditas dan komplikasi yang berhubungan dengan Kecelakaan Kerja atau PAK ditanggung oleh **PIHAK PERTAMA** sejak Peserta menjalani perawatan dan pengobatan yang meliputi Pelayanan Kesehatan pada saat rawat inap dan rawat jalan akibat kecelakaan kerja atau PAK sampai Peserta dinyatakan sembuh, cacat atau meninggal dunia; dan
4. Komorbiditas dan komplikasi dijamin setelah mendapatkan persetujuan dari **PIHAK PERTAMA**.

VIII. PENGgantian BIAYA ADMINISTRASI

1. Penggantian biaya administrasi rawat inap dan rawat jalan untuk biaya Pelayanan Kesehatan di **PIHAK KEDUA** mengacu pada **Tarif Fee for**

services yang setara tarif kelas 1 Rumah Sakit Pemerintah Dr. Soetomo di Provinsi Jawa Timur dengan ketentuan:

- a. maksimal 3% dari keseluruhan biaya Pelayanan Kesehatan; dan
 - b. paling banyak sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap kunjungan rawat jalan maupun setiap periode rawat inap dan menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**.
2. Biaya pendaftaran untuk setiap kunjungan rawat jalan maupun setiap periode rawat inap mengacu pada tarif Rumah Sakit Pemerintah Dr. Soetomo di Provinsi Jawa Timur.

IX. HAL-HAL YANG TIDAK DITANGGUNG

1. **PIHAK PERTAMA** tidak menanggung biaya Pelayanan Kesehatan bagi Peserta apabila termasuk dalam kategori sebagai berikut:
- a. penyakit akibat hubungan kerja (*work related diseases*) yaitu penyakit yang dicetuskan atau diperberat oleh pekerjaan atau lingkungan kerja;
 - b. tindakan mencelakakan diri sendiri yang dilakukan secara sengaja;
 - c. Kecelakaan Kerja dan PAK yang diakibatkan dari tindakan yang melanggar hukum;
 - d. obat yang mengandung ekstrak tumbuhan atau hewan, atau vitamin yang tidak sesuai dengan indikasi medis;
 - e. tindakan operasi dan obat-obat kosmetik yang bertujuan untuk estetik;
 - f. pengobatan komplementer, alternatif, dan tradisional, yang belum dinyatakan efektif berdasarkan penilaian teknologi kesehatan;
 - g. pengobatan dan tindakan medis yang dikategorikan sebagai percobaan atau eksperimen;
 - h. Pelayanan Kesehatan rujukan ke luar negeri; atau
 - i. kategori lainnya yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Dalam hal Peserta yang telah dijamin untuk dugaan Kecelakaan Kerja atau dugaan PAK dan telah mendapatkan Kesimpulan bukan Kecelakaan Kerja atau bukan PAK maka ketentuan hal yang tidak ditanggung diluar dari yang telah disebutkan pada angka 1 (satu) mengikuti ketentuan pada program JKN.

PIHAK KEDUA
RUMAH SAKIT DHARMA HUSADA
PROBOLINGGO

PIHAK PERTAMA
BPJS KETENAGAKERJAAN
KANTOR CABANG

dr. IFIT BAGUS APRIANTONO, M.MRS
DIREKTUR

(NAMA)
KEPALA KANTOR CABANG

LAMPIRAN II
PERJANJIAN KERJA SAMA
TENTANG
PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN
BAGI PESERTA PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA

Nomor: PER/ ... /.... (nomor PIHAK PERTAMA)
Nomor: (nomor PIHAK KEDUA)

TARIF PELAYANAN KESEHATAN

- I. Tarif pelayanan/perawatan sesuai berita acara negosiasi yaitu
- 1 ASUHAN KEPERAWATAN

NO	Tindakan Non Operatif	Asuhan Pasien (Rp)
1	asuhan pasien	200.000/ hari
2	pasang infus	
3	lepas infus	
4	konsultasi gizi	
5	administrasi RI	3% dari total tag RI
6	administrasi RJ	30,000
7	id card	5,000

Biaya administrasi rawat inap maksimal 3% dari keseluruhan biaya pelayanan kesehatan dan paling banyak sebesar 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap periode rawat inap.

1. TARIF LAYANAN

NO	URAIAN	TARIF
I	JASA DOKTER	
1	Dokter Umum/UGD	40.000
2	Dokter spesialis	85.000
3	Dokter subspesialis	85.000
II	UGD	
1	Dokter UGD	40.000
2	RESUSITASI	73.500
3	Observasi di UGD < 2 Jam	73.500
4	Observasi di UGD > 2 Jam < 6 jam	125.000
5	Observasi > 6 Jam	125.000
III	RAWAT INAP	
1	Visite dr Sp	110.000
2	Visite dr Subspesialis	125.000
3	Rawat Inap	250.000
4	HCU	225.000
5	ICU/ICCU	295.000

6	Isolasi	250.000
7	Intermediete	250.000
IV	HEMECARE	
1	Perawatan Luka Homecare	39.000
2	Homevisite Dokter Umum	70.000
3	Homevisite Dr Spesialis	200.000
4	Homevisite Perawat/Terapis/Analisis	100.000
5	Jasa Dokter	60.000
6	Jasa Perawat	150.000
7	Jasa Rehab	110.000
8	Tindakan Sederhana	100.000
9	Tindakan Sedang	150.000
V	LABORATORIUM	
1	Darah rutin	70.000
2	Darah lengkap	70.000
3	SGOT	42.000
4	SGPT	42.000
5	HBsAG	70.000
6	anti HBS	70.000
7	HIV	155.000
8	anti HIV penyaring	85.000
9	Ureum	42.000
10	Albumin	68.000
11	Analisa Gas Darah	238.000
12	Asam Urat Darah	42.000
13	Calsium Darah	50.000
14	Bilirubin	60.000
15	Kholesterol HDL	50.000
16	Kholesterol LDL	70.000
17	Kholesterol total	43.000
18	Kreatinin	42.000
19	Glucosa 2 jam PP	42.000
20	Glucosa Puasa	42.000
21	Glukosa Sewaktu	42.000
22	Trigliserida	42.000
23	Urin Rutin	42.000
24	ACA IG G	347.000
25	ACA IG M	489.000
26	ACID PHOSPATASE	151.800
27	ADENOSINE DEAMINASE	681.440
28	AFP	425.000
29	AMPHETAMINE	69.000
30	AMYLASE	209.400
31	ANA PROFIL TEST	1.780.000

32	ANA TEST	674.125
33	ANALISA BATU	367.000
34	ANALISA CAIRAN ASCITES	289.200
35	ANALISA CAIRAN CAPD	291.000
36	ANALISA CAIRAN PLUERA	369.500
37	ANTI DHF IG G/M	248.400
38	ANTI HAV	598.000
39	ANTI HBC	369.500
40	ANTI HBE	369.500
41	ANTI HCV	598.000
42	ANTI HSV IGG	466.750
43	ANTI HSV IGM	855.600
44	ANTI SARS COV-1 PARAMETER	150.000
45	ANTI SARS COV-2 PARAMETER	200.000
46	ANTI SARS COV-2 RUJUKAN RS/FASKES LAIN	100.000
47	ANTI TOXOPLASMA	234.000
48	APO A1	252.400
49	APO B	252.400
50	ASTO / ASO	204.000
51	BENCE JONES	24.840
52	BENZIDINE/FOBT	140.350
53	BENZODIAZEPAM	69.000
54	BETA HCG (KUANTITATIF)	360.700
55	BGA	227.200
56	BILE ACID	220.800
57	BIOPSI KECIL	325.000
58	BIOPSI ORGAN DALAM	325.000
59	BMP	1.500.000
60	CA - 125	750.000
61	CA 15 - 3	540.000
62	CA 19 - 9	843.000
63	CAIRAN KISTA OVARIUM	465.907
64	CEA	327.400
65	CHOLINESTERASE	338.000
66	CKMB	151.000
67	COCAINE	69.000
68	COOMB'S TEST	124.000
69	COOMB'S TEST DIRECT/INDIRECT	150.000
70	CORTISOL	241.500
71	CPK / CK	108.000
72	CROSSMATCH TEST	115.000
73	CRP	96.600

74	CRP (KUANTITATIF)	279.000
75	DARAH KULTURE	731.875
76	D-DIMER	924.000
77	DENGUE BLOTH	220.800
78	DIFTERI	103.920
79	DIPHThERIAE	411.900
80	DS DNA	669.000
81	DS DNA IG G/JG M	858.120
82	EGFR	34.500
83	ELEKTROLIT	186.000
84	EOSINOFIL	41.400
85	ESTRADIOL	354.000
86	FECES KULTURE	525.000
87	FECES LENGKAP (FL)	27.600
88	FERITIN	425.000
89	FIBRINOGEN	204.600
90	FNAB > 1 TITIK	550.000
91	FNAB 1 TITIK	350.000
92	FNAB SLIDE/TANPA PASIEN	195.000
93	FNAB/BIOPSI JARUM HALUS PERMUKAAN	364.000
94	FOSFATE ALKALI	227.000
95	FOSFOR ANORGANIK	51.750
96	FREE T3	486.000
97	FREE T4	300.000
98	FRUKTOSAMIN	289.800
99	FSH	255.300
100	FT3 (ELCIA)	305.000
101	FT4 INDEX	324.300
102	G-6PD	172.500
103	GALL KULTUR	138.000
104	GAMMA GLOBULIN	34.500
105	GAMMA GT	227.000
106	GO	144.000
107	GOLONGAN DARAH ABO / RHESUS	34.500
108	GRAM	109.000
109	GRAM SPUTUM	193.688
110	GROSS TITRASI	48.300
111	GTTOT	138.000
112	HAPUSAN DARAH	89.700
113	HB A 1 C	248.400
114	HB ELECTROFORESIS	566.400
115	HBE AG	598.000
116	HBS AB (EIA)	137.770

117	HBS AB (RPHA)	62.100
118	HBV DNA (KUALITATIF)	1.831.250
119	HEMOGLOBIN	30.000
120	HITUNG JENIS LEKOSIT	13.800
121	HS CRP (KUALITATIF)	404.000
122	ICT - TB	241.680
123	ICT MALARIA	598.000
124	IG A	255.300
125	IG A NEUFROPATI	600.000
126	IG E	372.250
127	IG G	255.278
128	IG G / IG M HAV	177.500
129	IG G / IG M LEPTOSPIROSIS	711.774
130	IG G / M H.PYLORI	212.500
131	IG G ANTI HBC	250.110
132	IG G ANTI HSV I	669.000
133	IG G ANTI HSV II	669.000
134	IG G CMV	669.000
135	IG G RUBELLA	598.000
136	IG G TOXOPLASMA	425.000
137	IG M	255.300
138	IG M ANTI HSV I	669.000
139	IG M ANTI HSV II	669.000
140	IG M CMV	669.000
141	IG M RUBELLA	598.000
142	IG M TOXOPLASMA	425.000
143	IGG /IGM LEPTOSPIROSIS	645.600
144	IGM ANTI SALMONELLA	324.282
145	IGM ANTI-HAV	598.000
146	IGM ANTI-HBC	394.500
147	IGRA	1.650.000
148	INR	91.080
149	INSULIN	240.000
150	INSULIN PUASA	240.000
151	INTERLEUKIN 6 (IL6)	1.400.000
152	KALIUM	42.000
153	KEROKAN	422.500
154	KPPT/APPT	75.900
155	KULTUR CAIRAN PLEURA	305.900
156	KULTUR H - PHYLORI	752.000
157	KULTUR LUKA OPERASI	138.000
158	KULTUR PUS	588.000
159	KULTUR SPERMA	138.000
160	KULTUR USAP TENGGOROK	570.000

161	LDL CHOLESTEROL	70.000
162	LEUCOSIT	13.800
163	LH	255.300
164	LIPASE	202.700
165	LIPID PROFILE	149.500
166	LIPID TOTAL	55.200
167	LP (A)	276.000
168	LUPUS ANTICOAGULANT	523.710
169	MAGNESIUM	284.000
170	MALARIA	33.350
171	MANTOUX TEST	90.000
172	MEPTHAPHETAMINE	69.000
173	MORPHINE	69.000
174	NARKOBA 7 PARAMETER	193.000
175	NS ONE DENGUE	358.800
176	NSE	650.000
177	PA CAIRAN	276.000
178	PA GOL 1 (BPJS)	150.000
179	PA GOL I	930.000
180	PA GOL II	735.000
181	PA GOL II (BPJS)	180.000
182	PA GOL III	472.500
183	PA GOL III (BPJS)	333.000
184	PA GOL V	472.500
185	PA MAMAE	3.000.000
186	PA OPERASI BESAR	520.000
187	PA OPERASI SEDANG	422.500
188	PA1 dan PA2	320.000
189	PAPSMEAR	154.700
190	PCR SWAB COVID-19	275.000
191	PENGECATAN KOH	62.500
192	PENGECATAN SWAB TENGGOROK	143.750
193	PEWARNAAN CAIRAN	90.000
194	PHLEBOTOMI	10.000
195	PPT	69.000
196	PREGNOCTION PLANO TEST	27.600
197	PREPARAT BTA	38.000
198	PREPARAT BTA SPS	121.500
199	PROGRAM DINKES EID	70.000
200	PROGRAM DINKES HIV / ICT 3 REAGEN	59.000
201	PROGRAM DINKES PREPARAT BTA	72.000
202	PROGRAM DINKES TPHA	57.000

203	PROGRAM DINKES VIRAL LOAD	70.000
204	PROLACTINE	255.300
205	PROSTATE PHOSPATASE	220.800
206	PROTEIN ESBACH	107.000
207	PROTEIN URINE	15.000
208	PSA	598.000
209	RAPID ANTIGEN STAF DPM	50.000
210	RAPID TEST ANTIGEN	73.000
211	RAPID TEST COVID-19 (UTAMA)	390.000
212	RECTAL SWAB	348.500
213	REMATHOID ARTHRITIS / RA TES	69.000
214	RESISTENSI OSMOTIC	69.000
215	RETIKULOSIT	211.000
216	ROOSE WEALER	103.350
217	ROTA VIRUS	207.000
218	RUMPLE LEEDE	6.900
219	SEKRET KULTURE	436.000
220	SEL LE	69.000
221	SERAMUBA	306.360
222	SERUM ION	228.000
223	SITOLOGI CAIRAN ASCITES	258.401
224	SITOLOGI CAIRAN PLEURA	517.000
225	SITOLOGI SPUTUM	186.400
226	SPUTUM	130.000
227	SPUTUM KULTURE	662.575
228	Swab Tenggorok	305.900
229	T B K	345.000
230	T4 (ELCIA)	331.825
231	T4 (TOTAL)	258.000
232	TB TEST / TB DOT	198.000
233	TES ANTI HIV / ICT 3 REAGEN	252.000
234	TES TCM PROGRAM DINKES	25.000
235	TEST PACK	55.200
236	TEST PLANO TITRASI	55.200
237	TESTOSTERON	255.300
238	THC	69.000
239	TIBC	228.000
240	TOTAL PROTEIN	82.000
241	TOXOPLASMA IHA	156.000
242	TPHA	227.000
243	TRICTOMONAS	27.600
244	TROPONIN I	288.000
245	TSH	282.000

246	UREA CLEARANCE	48.000
247	URIC ACID	36.000
248	Urine Kultur	662.575
249	URINE LENGKAP	30.000
250	VDRL	211.000
251	VITAMIN D 25-OH TOTAL	750.000
252	VVP PREPARAT	60.000
253	WEIL FELIX	145.800
254	WIDAL	43.500
255	WIDAL FELIX	117.300
VI	RADIOLOGI	
1	Rontgen kepala	200.000
2	Clavikula	175.000
3	Torax	141.000
4	Femur	175.000
5	Tibia cruris	158.000
6	Pelvis	115.000
7	Lumbal	125.000
8	Hip Joint	175.000
9	Abdomen Polos	120.000
10	Angkle	120.000
11	Antebrachi	120.000
12	Shoulder	120.000
13	Cervical	120.000
14	Genu	120.000
15	Humerus	115.000
16	Manus	120.000
17	Pelvis	120.000
18	Pedis	120.000
19	Tmj	115.000
20	Rahang	117.000
21	Digiti	120.000
22	Vertebrae	200.000
23	Apendikogram	1.450.000
24	Cystography	903.000
25	Babygram	210.000
26	Bno-Kub Dengan Kontras	800.000
27	Bno-Kub Tanpa Kontras	149.000
28	Colon In Loop	1.172.000
29	Cruris Dex	149.000
30	Cruris Sin	149.000
31	Elbow Dex	138.000
32	Elbow Sin	138.000
33	Humerus Dex	115.000

34	Humerus Sin	115.000
35	Ivp + Obat Kontras	972.000
36	Lumbosacralis Ap/Lat	141.000
37	Lumbosacralis Obl/Dex	141.000
38	Manus Dex	120.000
39	Manus Sin	120.000
40	Panoramik Gigi	245.000
41	Periapical	151.000
42	Thoraxcholumbal	227.000
43	Tmj (Temporo Mandibukar Joint)	178.000
44	Tranium	172.000
45	Ulna	171.000
46	Waters	178.000
47	Wrist	171.000
48	USG	
49	Abdomen Atas/Bawah/Lengkap	300.000
50	Digiti	450.000
51	Manus	450.000
52	Pergelangan Tangan/Kaki	450.000
53	Pedis/Genu	450.000
54	Bahu	450.000
55	Echocardiogram	500.000
56	Femur	350.000
57	Kepala	225.000
58	Mamae	225.000
59	Mandibula	225.000
60	Testis	225.000
61	Thyroid	225.000
62	Urologi	255.000
63	Vaskuler	500.000
64	Uterus	390.626
65	Thorax	450.000
VIII	CT scan	
1	CT scan kepala tanpa kontras	1.475.000
IX	EKG	66.000
X	REHABILITASI MEDIS	
1	Terapi Heat	150.570
2	Diathermy Terapi	80.000
3	Elektro Terapi	159.660
4	Laser Terapi	158.040
5	Facial Massage Exercise	133.560
6	Pasive Musculoskeletal Exercise	133.560
7	Active Musculoskeletal Exercise	133.740
8	Resisted Musculoskeletal Exercise	133.110

9	Assisting Exercise	189.540
10	Stretching Exercise	80.000
11	Gait Training Exercise	133.380
XI	paket rawat inap	
	Sewa kamar	250.000
XII	TINDAKAN MEDIS NON OPERATIF	
1	Ps Infus	47.250
2	Aff Infus	25.200
3	Ps Kateter	47.250
4	Aff Kateter	25.200
5	Injeksi Sub Cutan	25.000
6	Injeksi IV/IM	21.000
7	Angkat Drain	75.000
8	Ngt	45.000
9	Suction	40.000
10	Memberikan Transfusi	21.000
11	Syringe Pump	75.000
12	Perawatan Luka Ringan	75.000
13	Perawatan Luka Sedang	100.000
14	Perawatan Luka Berat	125.000
15	Pasang Gips 2'	150.000
16	Pasang Gips 4'	185.000
17	Pasang Gips 6'	200.000
18	Pasang Perban	100.000
19	Buka Gips	150.000
20	Pasang Spalk	110.000
21	Hecting <10 Simpul	150.000
22	Hecting >10 Simpul	175.000
23	ANIMEK (PER LABU)	25.000
24	AUDIOMETRI	400.000
25	CHEMOTHERAPY OLEH SPOG	500.000
26	CIRCUMSISI	870.000
27	CORPUS ALIENUM	135.000
28	DC SHOCK	150.000
29	DOOPLER / KALI	2.500
30	DOPPLER / KALI	10.000
31	DRIP	500.000
32	EAR ENDOSKOPI	154.800
33	ECG MONITOR	100.000
34	EVAKUASI FECES	135.000
35	FACIAL BASIC	150.000
36	FISIOTERAPI	170.000
37	FOTO THERAPIE/SERI	100.000
38	GANTI CAIRAN INFUS	10.000

39	GLISERIN	144.000
40	IMUNISASI BCG	70.000
41	IMUNISASI CAMPAK	70.000
42	IMUNISASI DPT	70.000
43	IMUNISASI HBO	70.000
44	IMUNISASI POLIO	70.000
45	IMUNISASI TT	70.000
46	INCISI < 5 CM	420.000
47	INCISI > 5 CM	520.000
48	INFANT WARMER	30.000
49	INFUSE PUMP	75.000
50	INJEKSI HAEMOROID	600.000
51	INJEKSI INTRA ARTIKULER	200.000
52	INJEKSI KELOID	150.000
53	INJEKSI KISTA	220.000
54	INJEKSI STEROID	150.000
55	IRIGASI TELINGA	150.000
56	IRIGASI TRAUMA KIMIA	150.000
57	KASUR DECUBITUS / HARI	32.000
58	KONSULTASI GIZI	35.000
59	KULTUR	200.000
60	KUMBAH LAMBUNG	55.000
61	LEPAS CHEST TUBE	250.000
62	LEPAS IUD	300.000
63	LEPAS JAHITAN	200.200
64	LEPAS JAHITAN (DR)	152.000
65	LEPAS JAHITAN DOKTER GIGI	140.000
66	LEPAS KONDOM CATHETER	30.000
67	LEPAS KUKU	260.000
68	LEPAS PESARIUM	300.000
69	LEPAS SUSUK dr. Spesialis	350.000
70	LEPAS SUSUK dr. Umum	260.000
71	MANUAL PLASENTA	550.000
72	MEMANDIKAN BAYI	20.000
73	MEMANDIKAN/MENYEKA PASIEN	25.000
74	NASO ENDOSKOPI	370.000
75	NEBULIZER ANAK	28.000
76	NEBULIZER DEWASA	38.000
77	NST	96.600
78	OKSIGEN / HARI	100.000
79	PASANG CVC	1.055.000
80	PASANG CVC ISOLASI	1.055.000
81	PASANG DEUREMBES	135.000
82	PASANG KORSET UMUM	100.000

83	PASANG LAMINARIA	300.000
84	PASANG MAYO TUBE	15.000
85	PASANG PESARIUM	160.000
86	PASANG SUSUK	380.000
87	PATOLOGI ANATOMI	200.000
88	PELAYANAN TRANSFUSI DARAH	30.000
89	PEMBERIAN OBAT PER SUPPOSITORIA	7.000
90	PERAWATAN TALI PUSAT	2.500
91	PIJAT BAYI	50.000
92	PLEURODESIS	150.000
93	PROOF PUNKSI	250.000
94	PROOF PUNKSI SUB MANDIBULA	650.000
95	PSIKOTERAPI SUPPORTIVE	100.000
96	PUNKSI ASITES (DR. SPESIALIS)	485.000
97	PUNKSI ASITES OLEH DR. UMUM	435.000
98	PUNKSI BLAST OLEH DR. UMUM (NON BHP)	300.000
99	REDUCTION HAEMOROID	150.000
100	RESUSITATOR (AMBUBAG, MAYO)	55.000
101	SKIN TEST	15.000
102	SKIREN	5.000
103	SONDE	5.000
104	SPIROMETRI	320.000
105	SUCTION PUMP	65.000
106	SUNTIK KB	36.000
107	SYRINGE PUMP / 24 JAM	75.000
108	TINDAKAN INTUBASI	500.000
109	TINDAKAN INTUBASI ISOLASI	830.000
110	TINDAKAN SPOOLING	190.000
111	TINDAKAN TCA	100.000
112	TINDAKAN TUTUL TCA/KOH	110.000
113	TLOOD PAB	120.000
114	UROFLEMETRI	425.000
115	VENTILATOR/HARI	500.000
116	VITAL SIGN	5.000
XIII	ADMINISTRASI	
1	rawat jalan/UGD	30.000
2	rawat inap	3% dari total tag RI

2. TARIF TINDAKAN OPERASI

A. Operasi Kecil

NO	Komponen	Operasi Kecil
		I,II,III
1	Sewa OK	1,294,029
2	Jasa Dokter Bedah	1,173,275
3	Dokter Anastesi	351,983
4	Asisten Bedah	87,996
5	Asisten Anastesi	26,399
6	Instrumen	50,000

B. Operasi Sedang

NO	Komponen	Operasi Sedang
		I,II,III
1	Sewa OK	1,626,152
2	Jasa Dokter Bedah	1,984,865
3	Dokter Anastesi	595,459
4	Asisten Bedah	148,865
5	Asisten Anastesi	44,659
6	Instrumen	50,000
7	Onloap	50,000
8	Sewa Alat	500,000
	Total Operasi Sedang	5,000,000

C. Operasi Besar

NO	Komponen	Operasi Besar
		I,II,III
1	Sewa OK	1,946,042
2	Jasa Dokter Bedah	3,258,646
3	Dokter Anastesi	977,594
4	Asisten Bedah	244,398
5	Asisten Anastesi	73,320
6	Instrumen	50,000
7	Onloap	50,000
8	Sewa Alat	500,000
	Total Operasi Besar	7,100,000

D. Operasi Khusus

NO	Komponen	Operasi Khusus
		I,II,III
1	Sewa OK	2,653,117
2	Jasa Dokter Bedah	5,543,387
3	Dokter Anastesi	1,663,016
4	Asisten Bedah	415,754
5	Asisten Anastesi	124,726
6	Instrumen	50,000
7	Onloap	50,000
8	Sewa Alat	500,000
	Total Operasi Khusus	11,000,000

II. Tarif Pelayanan medis operatif/Tindakan operatif kondisi tertentu bagi Peserta yang mengalami Kecelakaan Kerja/PAK (sesuai perjanjian)

Perhitungan tarif pada pelayanan medis operatif/tindakan operasi diklasifikasikan menjadi beberapa hal berikut:

- a. Dalam hal dilakukan dua atau lebih tindakan medis operatif secara bersamaan pada pasien yang sama, dengan operator lebih dari satu orang (bukan kasus fragmentasi), mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - a.1 Tindakan Operatif Utama:
Operator pertama yang melakukan tindakan operatif utama dikenakan tarif 100% sesuai dengan paket tindakan operatif atau tarif yang berlaku. Ini merupakan tindakan yang paling kompleks atau penting yang dilakukan selama prosedur.
 - a.2 Operator Kedua (atau Lebih):
Jika ada operator lain yang melakukan tindakan operatif tambahan secara bersamaan pada pasien yang sama, operator kedua juga dihitung sebesar 100% atau sesuai tarif yang berlaku.
 - a.3 Tindakan Anestesi:
Untuk tindakan anestesi, jasa pelayanan anestesi dihitung maksimal sebesar 40% dari tarif jasa pelayanan operator yang terlibat dalam tindakan operatif tersebut.
- b. Dalam hal dilakukan dua atau lebih tindakan medis operatif (bukan kasus fragmentasi) yang dilakukan oleh satu operator dalam waktu bersamaan pada pasien yang sama, mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - b.1 Tindakan Operatif Utama:
Tindakan operatif utama dihitung sebesar 100% (seratus persen) dari tarif atau sesuai dengan tarif paket tindakan operatif yang berlaku. Tindakan ini adalah prosedur yang dianggap paling kompleks atau utama yang dilakukan selama operasi.
 - b.2 Tindakan Operatif Kedua dan Seterusnya pada regio atau lokasi tubuh yang sama:
Untuk tindakan operatif kedua dan selanjutnya yang dilakukan dalam waktu bersamaan oleh operator yang sama, tarifnya dihitung maksimal sebesar 60% (enam puluh persen) dari tarif tindakan tersebut.
 - b.3 Tindakan Operatif Kedua dan Seterusnya pada regio atau lokasi tubuh yang berbeda:
Untuk tindakan operatif kedua dan selanjutnya yang dilakukan dalam waktu bersamaan oleh operator yang sama, tarifnya dihitung maksimal sebesar 80% (delapan puluh persen) dari tarif tindakan tersebut.
- c. Tindakan medis reoperasi adalah tindakan operasi ulang untuk melakukan revisi atas tindakan operasi pertama dan dilakukan masih dalam *masa perawatan, maka diatur:
 - c.1 Reoperasi ke-1 (kesatu) diberikan sebesar maksimal 75% (tujuh puluh persen) dari tarif tindakan medis operatif;
 - c.2 Reoperasi ke-2 (kedua) dan ketiga, 50% (lima puluh persen) dari jasa;

- dan
- c.3 Reoperasi selanjutnya dibebaskan dari jasa operasi.
*masa perawatan adalah periode dimana pasien berada dalam masa rawat inap.
- d. Tindakan medis operatif yang menggunakan atau didampingi oleh dokter ahli/spesialis pendamping lain (non bedah), tarif untuk dokter ahli/spesialis pendamping adalah maksimal sebesar 20 % (dua puluh persen) dari jasa pelayanan operator.

III. **Penggolongan Tindakan Operasi bagi Peserta yang mengalami Kecelakaan Kerja/PAK (sesuai perjanjian)**

1. Operasi *cito* adalah tindakan bedah yang harus segera dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi pasien untuk mendapatkan hasil optimal bagi keselamatan pasien, dilakukan dalam kurun waktu 6 (enam) jam sejak pasien di asesmen oleh Dokter Penanggungjawab Pasien (DPJP).
2. Tarif Tindakan *cito* adalah sebesar biaya operasi terencana.
3. Setiap tindakan operatif melampirkan salinan hasil laporan operasi yang minimal memuat :
 - 3.1. jenis dan tindakan operatif;
 - 3.2. diagnosa penyakit;
 - 3.3. tanggal dan waktu tindakan operatif;
 - 3.4. jumlah dan nama dokter yang melakukan operatif;
 - 3.5. ringkasan tindakan operatif; dan
 - 3.6. kesulitan dan komplikasi yang mungkin terjadi selama tindakan operatif.
4. Daftar pengelompokan tindakan operatif orthopedi sebagai berikut:

PENGGOLONGAN TINDAKAN OPERATIF ORTHOPEDI

I. **KNEE**

NO	GOLONGAN TINDAKAN	NAMA PENYAKIT – TINDAKAN
1	SEDANG II	Tindakan dilakukan dengan anestesi local
2	SEDANG III	Closed Reduction knee
3	BESAR I	Open Reduction knee
4	BESAR III	ORIF
5	KHUSUS I	1. ORIF Advance 2. Arthroscopy Diagnostic 3. Open knee debridement 4. Arthroscopy debridement knee 5. Arthroscopy remove loose body 6. Arthroscopy Meniscectomy 7. Arthroscopy Synevectomy knee

6	KHUSUS II	1. Arthroscopy meniscus repair 2. Microfracture 3. Single ligament reconstruction of the knee 4. Primary total Knee Replacement 5. Autogenous Chondrocyte Implantation 6. Osteotomy around the knee (HTO/DFO)
7	KHUSUS III	1. I Revisi TKR 2. Difficulty primary total knee replacement 3. Multiligament reconstruction of the knee 4. Ligament reconstruction + meniscus/cartilage repair

II. SPINE

NO	GOLONGAN TINDAKAN	NAMA PENYAKIT - TINDAKAN
1	SEDANG II	1. Mayor degloving, wound debridement and repair of the spine 2. Plaster application of extremity & spine 3. Traction application of the spine
2	SEDANG III	1. Biopsy Vertebra (1 level) 2. Manipulation & reduction of simple fracture and dislocation with general anaesthesia. 3. Body cast / Halo vest / Minerva application
3	BESAR I	1. Discograph (1 level)
4	BESAR II	1. Removal of Implants (plate, nail, screw) 2. Discograph (Mult ilevel)
5	BESAR III	1. IDET 1(1 level) 2. Open Disectomy (1 level) 3. Thermal Disc 4. Facet Block 5. Radiofrequency 6. CESI 7. Foraminal Block / Selective nerve root block 8. Percutaneous Laser Disc Decompression (PLDD)

III. TRAUMA

NO	GOLONGAN TINDAKAN	NAMA PENYAKIT – TINDAKAN
1	KECIL	1. Tindakan dilakukan dengan anestesi local 2. External Fixation Wire/Schanz Pin (Only) Revision and/or Removal 3. Screw (only) removal/Revision (i.e syndesmotic screw, removal of interlocking screw for dynamization) 4. Secondary /Delayed Primary Suturing of wounds
2	SEDANG	1. Debridement of Wound (without Fracture) 2. Removal of External Fixation (without Conversion to other fixation) 3. Antibiotic Bone Spacer/Beads Insertion or Exchange (without fixation / revision of fixation) 4. Bone Graft insertion (without fixation or revision of fixation) 5. Skin graft (Full or Split Thickness) 6. Manipulation of Joints Under Anesthesia

		7. Fasciotomy for Compartment syndrome or other diagnosis (without fixation) 8. Local Skin Flap for wound closure (without fracture)
3	BESAR	1. Fixation of Simple Extraarticular Fracture (internal fixation, external fixation) 2. Closed Reduction +/- Circular Cast / Splint 3. Temporary Fixation by external fixation (for Damage Control Orthopedics/Part of Staged Fixation) 4. Debridement of Open Fracture +/- temporary external fixation 5. Debridement of Osteomyelitis/Infected Fracture (without Fixation / revision of fixation) 6. Amputation (primary / revision) 7. Arthrodesis 8. Removal of Hardware 9. Joint contracture release
4	KHUSUS I	1. Fixation of Multiple Extraarticular Fracture 2. Fixation of Complex Extraarticular Fracture (Proximal Femur, Comminuted diaphyseal, Bone Loss, Neglected, etc) 3. Intraarticular/Periarticular Fracture Fixation (other than Acetabular Fracture) 4. Revision Surgery (Internal Fixation/External Fixation/Other) of Extrarticular Fracture 5. Flap (Pedicled/Regional for Soft Tissue Defects of the Limb (without bone procedure) 6. Corrective Osteotomy 7. Debridement of Osteomyelitis/Fracture Related Infection (with Fixation/Revision of Fixation) 8. Osseointegration procedure for Amputation 9. Distraction Arthroplasty 10. Limb Lengthening 11. Conversion to Internal Fixation after Bone Lengthening/Transport

5	KHUSUS II	1. Fixation of Pelvis and Acetabular Fracture 2. Fixation of Intraarticular Fracture with Ligament Repair or Reconstruction 3. Fixation of Multiple Intraarticular Fracture 4. Revision Surgery (Internal Fixation/External Fixation/Other) of Intraarticular Fracture 5. Fixation of Fracture combined with Soft Tissue Coverage procedure (Regional Flap and/or Skin Graft) 6. Critical-Sized Bone Defect Reconstruction (Distraction Osteogenesis, Masquelet, Vascularized Bone Graft.) without soft tissue procedure 7. Flap (Free-Flap) for Soft Tissue Defects of the Limb (without bone procedure)
6	KHUSUS III	1. Revision of Pelvis and Acetabular Fracture 2. Critical-sized Bone Defect Reconstruction (Distraction Osteogenesis, masquelet, Vascularized Bone Graft, etc) with Soft Tissue Procedure (Flap, Tendon Lengthening, Release, etc) 3. Fixation of Fracture combined with Soft Tissue Coverage procedure (Free Flap) 4. Joint Replacement (for Intraarticular Fracture, Periarticular Nonunion/Malunions, and/or Muskuloskeletal Infection) 5. Megaprosthesis/Endoprosthesis (for Severe Fracture, periarticular bone defects and/or Muskuloskeletal Infection)

IV. HAND

NO	GOLONGAN TINDAKAN	NAMA PENYAKIT – TINDAKAN
1	KECIL	Tindakan dilakukan dengan anestesi local
2	SEDANG III	1. Angkat K-wire tanpa anesthesia/ regional 2. Tendon sheath & Jaringan subkutis, ganglion /small bursa, excision 3. Sendi (Extremitas atas) Rush rods/wires/screws removal 4. Nail bed, laceration, repair (single)
3	BESAR I	1. Tendon – extensor (extremitas atas) injury, repair (single) 2. Tendon Sheath (extremitas atas), tenosynovitis (single) , drainage 3. Jari, injury, debridement 4. Jari, Superficial infection, drainage 5. Jari, wart /corn/naevus, excision 6. Jari, various, amputasi (single) 7. Jari, deep infection, drainage 8. Jari, crush injury (simple), wound debridement 9. Tendon sheath (extremitas atas) ganglion/ villo nodular synovitis excision 10. Tendon Sheath (extremitas atas), trigger jari (single) release
4	BESAR II	1. Jari, scar, revision Osteotomy 2. Jari /Digit, Stump, revision 3. Nail Bed, laceration, repair (multiple) 4. Jari, foreign body (superficial), removal with mobilization of neurovascular bundle 5. Jari, Jaringan lunak tumor, excision 6. Tendon (ekstremitas atas), Bowstringing/ entrapment, pulley rekonstruksi 7. Tendon sheath (ekstremitas atas), tenosynovitis (multiple) , drainage 8. endon sheath (ekstremitas atas), tenosynovitis (multiple) , drainage 9. Carpus, fracture/ dislocation, reduksi terbuka dan fiksasi interna 10. Jari, crush injuries (complex) wound debridement
5	BESAR III	1. Tendon (Ekstremitas atas) contracture , tenotomy 2. Kulit dan jaringan subkutis, Laceration (Superficial) of more than 7 cm, repair 3. Sendi (jari), various lesions, arthrodesis

6	KHUSUS I	1. Nerve, Various lesions, biopsy 2. Kulit dan jaringan subkutis , Defect (Single digit) , Free full thickness graft 3. Jari, various lesions, Ray amputasi (Single) 4. Nerve (Ekstremitas atas) , Entrapment syndrome (others) , decompression (unilateral) 5. Nerve (Ekstremitas atas) , Entrapment syndrome (others) , decompression (unilateral) 6. Nerve (Ekstremitas atas), Guyon's tunnel syndrome, release (unilateral) 7. Tendon sheath (ekstremitas atas) , De Quervain's (unilateral), release 8. Tendon Sheath (ekstremitas atas), trigger jari (Multiple), release 9. Jari, Defect/ contracture (single) rekonstruksi 10. Jari, trauma, terminalisation (single) 11. Jari, Closed fracture/ dislocation, reduksi terbuka dan fixation (single) 12. Jaringan lunak (palmar space) abscess, drainage 13. Jari, Defect/ contracture (multiple) rekonstruksi 14. Jari, ring constriction (single), koreksi 15. Jari, trauma, terminalisation (single) 16. Jari, Deformities, osteotomy 17. Tendon - flexor (Ekstremitas atas) injury, tendon graft 18. Tendon - flexor (Ekstremitas atas) adhesion, tenolysis (multiple) 19. Nerve (Ekstremitas atas) , carpal tunnel syndrome, release (bilateral with endoneurolysis) 20. Nerve (Ekstremitas atas), Entrapment syndrome (others), Decompression (Bilateral) 21. Nerve (Ekstremitas atas), Entrapment syndrome (others), Decompression with nerve transposition /endoneurolysis 22. Nerve (Ekstremitas atas), guyon's Tunnel syndrome, release bilateral with endoneurolysis) 23. Tendon sheath (ekstremitas atas), De Quervain's (Bilateral), release 24. Thumb, deformities, koreksi 25. Jari, tumors, Excision with dissection of neurovascular bundle 26. Carpus, Delayed / Non union, rekonstruksi 27. Jari, ring constriction (multiple), koreksi 28. Jari, Syndactyly (multiple)
---	----------	--

		29. Tendon - flexor (ekstremitas atas), adhesion, tenolysis (multiple) 30. Tendon – flexor (ekstremitas atas) , Defect grafting (single)
6	KHUSUS II	1. Nerve digital, injury, Microsurgical (single) 2. Nerve ulnar, entrapment, transposition 3. Elbow , tennis elbow, release 4. Elbow (Medial epicondyle) , fracture , excision bony fragment 5. Jari, various lesions, amputasi (multiple) 6. Artery, large, Injury, repair with grafting 7. Sendi (wrist), Various lesions, Arthrodesis 8. Nerve-Digital, injury, microsurgical repair (multiple) 9. Nerve (ekstremitas atas), major, injury, microsurgical, repair (single) 10. Thumb, paralysis, opponens plasty 11. Jari, deformity, intrinsic muscle release / transfer / extensor relocation 12. Jari, deformities, major reconsructive procedure 13. Jari, fracture / dislocation, reduksi terbuka dan fiksasi interna (multiple) 14. Head-face, trauma, craniofacial approach reduction dan fixation 15. Sendi (jari), various lesions, replacement arthroplasty
7	KHUSUS III	1. Kulit dan jaringan subkutis, defect (Deep) staged distant flap (Division) 2. Kulit dan jaringan subkutis, defect (Multiple digits) staged local flap (Division) 3. Kulit dan jaringan subkutis, defect (Deep) staged distant flap (division) 4. Nerve defect, peripheral graft 5. Nerve various lesions, primary / secondary suture 6. Jari, Swan neck/ Boutonniere deformity (single), koreksi 7. Jari, deformities, Koreksi 8. Jari, Syndactyly (single) Koreksi 9. Jari, polydactyly, amputasi with rekonstruksi 10. Sendi (jari), contracture, capsulectomy / capsulotomy 11. Nerve digital, injury, primary repair 12. Jari, Macrodactyly, debulking

V. HIP

NO	GOLONGAN TINDAKAN	NAMA PENYAKIT – TINDAKAN
1	SEDANG II	Tindakan dilakukan dengan anestesi local
2	SEDANG III	Closed reduction hip
3	BESAR I	Open reduction hip
4	BESAR II	ORIF
5	BESAR III	1. Hip arthroscopy diagnostic 2. Debridement
6	KHUSUS I	1. Advance ORIF 2. Simple Arthroscopy HiD 3. Hip Arthroscopy CAM Osteoplasty 4. Pincer resection 5. Subimpingement Resection 6. Gluteus tendon repair / snapping hip 7. Hamstring repair/reconstruction
7	KHUSUS II	1. Hemiarthroplasty 2. Advance Arthroscopy Hip 3. Primary Total Hip Replacement (THR) 4. ORIF with minimal invasive 5. Core decompression 6. Osteotomy around the hip 7. Single ligament reconstruction of the hip 8. Hip arthroscopy labral repair 9. Varus/ valgus derotational osteotomy
8	KHUSUS III	1. Revisi THR 2. Difficulty Primary total hip replacement 3. Multiligament reconstruction of the hip 4. Hip arthroscopy labral reconstruction 5. Ligamentum teres reconstruction 6. Periacetbular osteotomy 7. Arthroplasty Jari 8. Arthroscopy 9. Tendon Transfer 10.FFMT

VI. SPORT INJURY

NO	GOLONGAN TINDAKAN	NAMA PENYAKIT – TINDAKAN
1	KHUSUS I	1. Diagnostic: Arthroscopic (Knee) 2. Debridement: Arthroscopic (Knee) 3. Cartilage Defect Treatment 4. Microfracture : Arthroscopic 5. Lateral Release (combine) : Knee Arthroscopic

		and open surgery 6. Knee Arthrofibrosis release 7. Diagnostic : Arthroscopic (Ankle) 8. Debridement: Arthroscopic (Ankle) 9. Ankle Peroneal Tendon Repair 10. Management of Plantar Fasciitis (Arthroscopic) 11. Cartilage Problem in Ankle Treatment 12. Calcified Tendinosis Removal (Shoulder) 13. Management of Elbow Tendinosis 14. Tennis Elbow Release 15. Loose Body Removal: Arthroscopic (Elbow) 16. Diagnostic: Arthroscopic (Hip) 17. Debridement: Arthroscopic (Hip)
2	KHUSUS II	1. Colleteral Ligament Reconstruction (Knee) 2. Meniscus Repair : Arthroscopic 3. Discoid Menicus Treatment 4. Arthroscopic Assisted Internal Fixation (Knee) 5. Postero Lateral Corner Reconstruction 6. Management of Ankle Impingement: Arthroscopic 7. Sinus Tarsi Syndrome 8. Management of Achilles Problem 9. Management of Impingement Syndrome (Shoulder) 10. Open Rotator Cuff Repair 11. Repair Rotator Cuff Tears (Mini Open) 12. Biceps Tendon Repair and Tenodesis 13. Frozen Shoulder Treatment 14. Anterior – Inferior Instability : Open Repair 15. Adhesive Capsulitis Relase (Shoulder) 16. Arcomioclavicular Joint Treatment 17. Elbow Contracture Release: Arthroscopic 18. Wrist Sports Injury 19. TFCC Injury 20. Loose Body Removal: Arthroscopic (Hip) 21. Femoral Acetabular Impingement Management: Arthroscopic 22. Hip Extraarticular Management
3	KHUSUS III	1. ACL Reconstruction (single or double Bundle) : Arthroscopic 2. ACL Reconstruction Adolescence: Arthroscopic 3. PCL Reconstruction: Arthroscopic 4. Multi Ligament Reconstruction (Knee) 5. Revision of Ligament Reconstruction (Knee) 6. Meniscus Transplant 7. MPFL Reconstruction (combine): Arthroscopic and open surgery

		8. Chondrocyte Replantation: Arthroscopic (Knee) 9. Patella Instability Treatment 10. Sports related Osteotomy (Knee) 11. Management of Ankle Instability 12. Shoulder Instability Treatment 13. Arthroscopic Rotator Cuff Repair 14. Management of Irreparable Rotator Cuff Tears 15. Superior Labrum Anterior Posterior Lesion Repair (Shoulder) 16. Shoulder Anterior and Anteroinferior Instability : Arthroscopic Repair 17. Shoulder Posterior Instability Treatment 18. Shoulder Multi-Directional Instability Treatment 19. Management of Elbow Instability 20. Labrum Repair: Arthroscopic
--	--	---

VII. FOOT AND ANKLE

NO	GOLONGAN TINDAKAN	NAMA PENYAKIT – TINDAKAN
1	KECIL	Tindakan dilakukan dengan anestesi local
2	SEDANG	1. Injeksi intraarticular / intralesi tanpa guiding 2. Closed reduction untuk dislokasi sendi
3	BESAR I	1. Debridement terbuka 2. Release hammer toe (single) 3. Biopsi eksisi 4. Injeksi intraarticular dengan image guiding 5. Implant removal (simple) 6. Amputasi toes / disartikulasi IP, MTP joint 7. Ostectomy 8. Morton neuroma decompression / excision
4	BESAR II	1. Implant removal (dengan penyulit) 2. Arthrotomy debridement 3. Release tarsal tunnel 4. Release hemmer toe (multiple) 5. Amputasi ray, midfoot, hindfoot, ankle 6. Closed reduction + internal fixation 7. ORIF / CRIF fraktur forefoot 8. Tendon lengthening 9. Plantar fasciotomy 10. Syndesmosis fixation

5	KHUSUS I	1. Open repair Achilles tendon 2. Gastrocnemius recession 3. Osteotomy calcaneus 4. Arthroscopy diagnostik 5. Arthroscopy removal loose bodies 6. Tendon repair 7. Percutaneous pinning pada foot/ankle joint 8. Calcaneoplasty untuk Achilles tendinopathy 9. Open reduction untuk dislokasi sendi 10. ORIF fraktur ankle malleolus / bimalleolar 11. Cheilectomy 12. Peroneal retinaculum repair 13. Midfoot reconstruction (termasuk Lisfranc joint) 14. Release Baxter nerve entrapment
6	KHUSUS II	1. Arthroscopy foot/ankle capsular release 2. Percutaneous repair Achilles tendon 3. Hallux valgus reconstruction 4. Arthroereisis 5. Foot/ankle joint arthrodesis 6. ORIF intraarticular ankle joint dengan LCP 7. Single stage deformity correction 8. Achilles tendon reconstruction 9. Tendon transfer 10. Arthroscopic treatment for ankle impingement 11. Open ligament repair / reconstruction 12. ORIF fraktur midfoot, hindfoot 13. ORIF fraktur trimalleolar 14. Open technique for osteochondral lesion treatment 15. Plantar plate repair 16. Peroneal groove deepening 17. Weil osteotomy 18. Arthroscopy hindfoot, subtalar, forefoot 19. Endoscopy tendon, tendon sheath, sinus tarsi
7	KHUSUS III	1. Total ankle replacement 2. Revisi total ankle replacement 3. Supramalleolar osteotomy 4. Hallux valgus reconstruction dengan prosedur tambahan 5. Gradual deformity correction dengan Ilizarov technique 6. Distraction arthroplasty / arthrodesis dengan Ilizarov technique 7. Arthroscopy assisted internal fixation (ARIF) foot/ankle joint 8. Arthroscopy haglund resection 9. Arthroscopic ligament reconstruction / tendon

		transfer 10. Arthroscopic treatment for osteochondral lesion 11. Arthrodesis multiple joints
--	--	---

VIII. SHOULDER AND ELBOW

NO	GOLONGAN TINDAKAN	NAMA PENYAKIT – TINDAKAN
1	KECIL	Tindakan dilakukan dengan anestesi lokal
2	SEDANG	Biopsy shoulder/ elbow joint
3	BESAR I	Debridement shoulder / elbow joint
4	BESAR II	1. Percutaneus release ECRB 2. Hydrodilatation frozen shoulder
5	KHUSUS I	1. Open acromioplasty 2. ORIF Proximal humerus Neer 2 part 3. Ulnar nerve decompression +/- transposition 4. Ulnar nerve decompression +/- transposition
6	KHUSUS II	1. Suprascapular nerve block for adhesive capsulitis 2. Debridement for septic arthritis / osteomyelitis and prosthetic joint infection around shoulder and elbow joint 3. Open rotator cuff repair (<= 1 tendon) 4. ORIF proximal humerus Neer 3 part with bonegraft and PHILOS 5. ORIF distal humerus double column without olecranon osteotomy 6. Complex radial head fracture (ORIF/ resection) 7. Arthroscopic diagnostic shoulder/ elbow 8. Arthroscopic synovectomy/ remove loose body shoulder/ elbow 9. early repair of serratus anterior avulsion 10. Neurolysis of long thoracic nerve
7	KHUSUS III	1. Transtendineous rotator cuff repair 2. Single row arthroscopic rotator cuff repair 3. Transosseus equivalent/ suture bridge repair of rotator cuff- arthroscopy 4. Margin convergence repair in large massive rotator cuff repair 5. Muscle sliding repair in retracted rotator cuff repair

		6. Superior capsular reconstruction fascia lata for massive cuff tear 7. LHB capsular reconstruction for massive cuff tear 8. Arthroscopy rotator cuff repair with augmentation 9. Arthroscopic subacromial decompression 10. Arthroscopic subcoracoid decompression 11. Arthroscopy biceps tenodesis/ tenotomy 12. Mini open subpectoral tenodesis 13. Arthroscopy rotator interval release 14. Arthroscopy 360 degree capsular release in adhesive capsulitis 15. Latissimus dorsi transfer for posterior superior cuff deficiency 16. Lower trapezius transfer for external rotation deficit of shoulder 17. Pectoralis major transfer for anterior superior cuff deficiency 18. Reverse shoulder arthroplasty for massive rotator cuff tear 19. Graft reconstruction for late pectoralis major rupture 20. Pectoralis major transfer for late deltoid rupture 21. Arthroscopic decompression for snapping scapula syndrome 22. Muscle transfer for scapular winging 23. Scapulothoracic fusion 24. AC Joint ligament reconstruction open / arthroscopy 25. Pectoralis major repair/ reconstruction for pectoralis major rupture 26. Latissimus dorsi repair/ reconstruction for latissimus dorsi rupture 27. Eden Hybinete for anterior recurrent shoulder dislocation 28. Glenoid bone reconstruction for anterior recurrent shoulder dislocation (open/ arthroscopy) 29. Arthroscopy capsulolabral repair for shoulder instability 30. Arthroscopic bony bankart repair 31. Arthroscopic posterior labral repair 32. Arthroscopic SLAP repair 33. Arthroscopy capsular plication for multidirectional instability 34. Arthroscopic remplissage for hillsach lesion 35. Reverse Mclaughlin/ iliac crest bone graft to humeral head for posterior recurrent shoulder
--	--	--

		dislocation (open/arthroscopy) 36. Complex fracture of acromion 37. Complex fracture of scapular (open)/ revision 38. Complex fracture of proximal humerus 39. Hemiarthroplasty for 4 part proximal humerus fracture 40. Total/Reverse shoulder arthroplasty for 4 part proximal humerus fracture 41. Arthroscopic ECRB release for lateral epicondylitis 42. Medial collateral ligament reconstruction of elbow 43. Lateral collateral ligament reconstruction of elbow 44. Triceps tendon repair/reconstruction 45. Distal biceps tendon repair, button/ anchor, single/double incision 46. Ancones interposition arthroplasty for lateral compartment OA 47. Reconstruction elbow for stiff elbow and unreduced dislocation 48. Arthroscopy release lateral / medial epicondylitis Arthroscopic assisted for intraarticular fracture of elbow 49. Terrible triad of elbow 50. Complex intra articular distal humeral fracture with olecranon osteotomy 51. Radial head arthroplasty for complex radial head fracture 52. Total elbow arthroplasty for complex fracture 53. Elbow interpositional arthroplasty 54. Arthrosopic of osteochondritis dissecans of elbow
--	--	---

IV. Tarif pelayanan/perawatan bagi Peserta yang mengalami dugaan Kecelakaan Kerja/dugaan PAK

Tarif pelayanan/perawatan bagi Peserta yang mengalami dugaan Kecelakaan Kerja/dugaan PAK adalah menggunakan tarif INA-CBGs sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

V. Berita Acara Negosiasi

Berita Acara Negosiasi ini digunakan untuk negosiasi ketentuan tarif sebelum dilakukan perjanjian kerja sama atau adendum Perjanjian Kerja Sama. Bentuk Berita Acara Negosiasi Tarif Kerja Sama adalah sebagai berikut:

**BERITA ACARA
NEGOSIASI TARIF KERJA SAMA
NOMOR : BA/.../...**

Pada hari ini, Kamis tanggal 11 bulan Desember tahun 2025 (11-12-2025) pukul 10.00 WIB, antara BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Pasuruan dengan RS Dharma Husada telah diadakan negosiasi harga Tarif Kerja Sama tahun 2026 sesuai terlampir :

Hasil negosiasi tersebut diatas disetujui RS Dharma Husada Probolinggo dan BPJS Ketenagakerjaan Kantor Caban Pasuruan serta ditandatangani oleh yang berhak dan mewakili dibawah ini.

Demikian berita acara ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

RS Dharma Husada Probolinggo	BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Pasuruan
(dr. Ifit Bagus Apriantono, M.MRS) (Direktur Rumah Sakit)	(.....) (jabatan)

SAKSI

1. nama : (saksi PIHAK PERTAMA)
jabatan

2. nama : (saksi PIHAK KEDUA)
jabatan

PIHAK KEDUA
(RS DHARMA HUSADA PROBOLINGGO)

PIHAK PERTAMA
BPJS KETENAGAKERJAAN
KANTOR CABANG

dr. IFIT BAGUS APRIANTONO, M.MRS
DIREKTUR

(NAMA)
KEPALA KANTOR CABANG

LAMPIRAN III
PERJANJIAN KERJA SAMA
TENTANG
PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN
BAGI PESERTA PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA

Nomor: PER/ ... /.... (nomor PIHAK PERTAMA)

Nomor: (nomor PIHAK KEDUA)

TATA CARA PENGAJUAN DAN PEMBAYARAN TAGIHAN
BIAYA PELAYANAN KESEHATAN

I. Tata Cara Pengajuan Tagihan Biaya Pelayanan Kesehatan

1. Dokumen kelengkapan pengajuan tagihan biaya Pelayanan Kesehatan adalah sebagai berikut :
 - a. Kartu Peserta;
 - b. KTP atau Passport bagi Warga Negara Asing;
 - c. surat pengajuan tagihan pembayaran yang ditandatangani oleh pimpinan **PIHAK KEDUA** atau Pihak dari **PIHAK KEDUA** yang diberikan kewenangan beserta rincian tagihan biaya Pelayanan Kesehatan;
 - d. SKP;
 - e. kuitansi bermeterai cukup atau kuitansi digital elektronik;
 - f. bukti pembayaran iuran terakhir bulan berjalan **PIHAK KEDUA** atas kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan.
 - g. dokumen pendukung lainnya yang diperlukan.
2. Dalam hal Peserta telah disimpulkan Kecelakaan Kerja oleh **PIHAK PERTAMA** dan/atau PAK oleh dokter yang merawat/memeriksa dari **PIHAK KEDUA**, tagihan biaya Pelayanan Kesehatan disampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** dengan ketentuan:
 - a. Biaya Pelayanan Kesehatan sebelum Kesimpulan KK/PAK menggunakan tarif INA CBGs sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 - b. Biaya Pelayanan Kesehatan setelah Kesimpulan KK/PAK menggunakan tarif sebagaimana diatur dalam lampiran II Perjanjian Kerja Sama,
3. Dalam hal Peserta telah dinyatakan sembuh, cacat atau meninggal dunia persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 1 ditambahkan surat keterangan dokter kasus kecelakaan kerja atau surat keterangan dokter kasus PAK (Formulir 3b KK 3 untuk kasus Kecelakaan Kerja atau formulir 3b PAK 3 untuk kasus PAK);
4. Selain dokumen sebagaimana angka 1 dan angka 2 diatas, **PIHAK PERTAMA** dapat meminta dokumen antara lain:
 - a. Hasil penunjang pelayanan medis;
 - b. Laporan tindakan medis;
 - c. resume medis Peserta;

- d. formulir Kecelakaan Kerja tahap I (Form 3 KK 1) atau formulir Penyakit Akibat Kerja tahap I (Form 3 PAK 1) apabila disampaikan melalui **PIHAK KEDUA**; dan/atau
 - e. surat rujukan antar PLKK yang digunakan sebelumnya,
5. Dalam hal pengajuan tagihan dilakukan secara daring, dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf e tetap disampaikan secara fisik kepada **PIHAK PERTAMA**.
 6. Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 5, disampaikan secara fisik kepada **PIHAK PERTAMA** paling lama 3 (tiga) hari setelah pengajuan secara daring dari **PIHAK KEDUA**.
 7. **PIHAK PERTAMA** melakukan pengecekan kelengkapan berkas dokumen pengajuan tagihan biaya Pelayanan Kesehatan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak pengajuan tagihan biaya Pelayanan Kesehatan diterima oleh **PIHAK PERTAMA**.
 8. Dalam hal dokumen tidak lengkap, **PIHAK PERTAMA** menginformasikan dan mengembalikan berkas dokumen pengajuan tagihan biaya Pelayanan Kesehatan kepada **PIHAK KEDUA** untuk dilengkapi dan ditagihkan kembali pada penagihan bulan berikutnya dengan ketentuan tidak melewati kadaluarsa klaim.
 9. **PIHAK PERTAMA** melakukan proses Verifikasi berkas klaim paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak berkas dinyatakan lengkap yang dibuktikan dengan dokumen penyampaian informasi kelengkapan dengan ketentuan:
 - a. dalam hal hasil Verifikasi menyatakan dokumen telah sesuai dan benar maka pembayaran dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak dokumen terverifikasi dibuktikan dengan hasil Verifikasi;
 - b. dalam hal hasil verifikasi menyatakan dokumen tidak sesuai maka **PIHAK PERTAMA** menyampaikan kepada **PIHAK KEDUA** untuk melakukan penyesuaian dokumen tagihan;
 - c. penyesuaian dokumen tagihan sebagaimana dimaksud huruf b disampaikan kembali kepada **PIHAK PERTAMA** paling lambat 2 (dua) hari kerja;
 - d. dalam hal **PIHAK KEDUA** tidak melakukan penyesuaian dan tidak menyampaikan kembali dokumen tagihan kepada **PIHAK PERTAMA** sesuai jangka waktu sebagaimana dimaksud huruf c maka **PIHAK PERTAMA** mengembalikan dokumen tagihan kepada **PIHAK KEDUA**; dan
 - e. dokumen tagihan sebagaimana dimaksud pada huruf d dapat diajukan kembali bersamaan dengan pengajuan tagihan biaya Pelayanan Kesehatan pada bulan berikutnya dengan ketentuan tidak melewati kadaluarsa klaim.
 10. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi terdapat perbedaan pengajuan tagihan dari **PIHAK KEDUA** dengan pembayaran yang dilakukan **PIHAK PERTAMA**, **PIHAK KEDUA** menyampaikan penyesuaian nilai pada kuitansi sesuai dengan pembayaran yang dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** paling lama 3 (tiga) hari sejak pembayaran diterima oleh **PIHAK KEDUA**.

11. Kuitansi sebagaimana dimaksud pada angka 10, disampaikan oleh **PIHAK KEDUA** secara fisik kepada **PIHAK PERTAMA** dan kuitansi yang disampaikan sebelumnya oleh **PIHAK KEDUA** dinyatakan tidak berlaku.

II. Pengajuan Tagihan Biaya Pelayanan Kesehatan COB dengan PT. Jasa Raharja (Persero) dan asuransi lain.

1. Dalam hal Peserta mengalami Kecelakaan Kerja atau dugaan Kecelakaan Kerja di lalu lintas yang memenuhi syarat dan ruang lingkup penjaminan PT. Jasa Raharja, menjadi penjamin pertama adalah PT. Jasa Raharja yang dibuktikan dengan surat jaminan Jasa Raharja.
2. Dalam hal pembiayaan layanan kesehatan yang diberikan oleh PT. Jasa Raharja telah memenuhi batas plafon dan/atau telah 1 (satu) tahun sejak terjadinya Kecelakaan Kerja dugaan Kecelakaan Kerja di lalu lintas, **PIHAK KEDUA** menagihkan kelebihan biaya dari plafon yang dijamin oleh PT. Jasa Raharja kepada **PIHAK PERTAMA** dengan persyaratan pengajuan tagihan sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2 dan/atau angka 3 bagian I Lampiran III ini disertai dengan bukti pembayaran manfaat oleh PT. Jasa Raharja.
3. Dalam hal kasus penjaminan dilakukan oleh asuransi lain maka selisih biaya yang tidak ditanggung oleh asuransi tersebut dapat diajukan kepada **PIHAK PERTAMA** dengan persyaratan sebagaimana dimaksud angka 1, angka 2 dan/atau angka 3 bagian I Lampiran III ini ditambahkan dengan surat keterangan dari asuransi lain dimaksud yang telah melakukan penjaminan pertama.

III. Tata Cara Pembayaran

1. **PIHAK PERTAMA** melakukan pembayaran atas tagihan biaya Pelayanan Kesehatan dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak dokumen dinyatakan lengkap dan benar berdasarkan hasil verifikasi **PIHAK PERTAMA**.
2. Dalam hal batas waktu pembayaran klaim sebagaimana dimaksud angka 1 (satu) jatuh pada hari libur, maka pembayaran dilakukan pada hari kerja pertama berikutnya.
3. Pembayaran dilakukan ke rekening **PIHAK KEDUA** sebagai berikut:
Nama Rekening :.....
nomor rekening : ...
Bank :.....
Cabang :.....
4. Biaya transfer yang timbul atas pembayaran tagihan dimaksud menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.
5. **PIHAK PERTAMA** menyerahkan surat pembayaran tagihan biaya Pelayanan Kesehatan beserta bukti bayar, rincian pembayaran beserta keterangan selisih pembayaran kepada **PIHAK KEDUA**.

IV. Rekonsiliasi Tagihan

Rekonsiliasi tagihan dilakukan oleh **PARA PIHAK** setiap bulan untuk melakukan pencocokan data, transaksi dan pembayaran tagihan biaya Pelayanan

Kesehatan berdasarkan dokumen dan data yang ada pada **PARA PIHAK** agar terjadi sinkronisasi antar entitas pelaporan di masing-masing Pihak dalam hal pengakuan, pengukuran, pencatatan, dan penyajian hak dan kewajiban yang timbul dari pembayaran tagihan biaya Pelayanan Kesehatan.

Bentuk Berita Acara Rekonsiliasi sebagai berikut:

BERITA ACARA
REKONSILIASI TAGIHAN
NOMOR : BA/.../...

Pada hari ini tanggal....., bulan....., tahun, BPJS Ketenagakerjaan melakukan rekonsiliasi klaim tagihan biaya Pelayanan Kesehatan Puskesmas, periode bulan sd, Tahun, dengan rincian sebagai berikut:

Bulan Kasus Kejadian KK/PAK	Bulan pengajuan klaim	Jumlah Pengajuan (Rp)	Hasil Verifikasi (Rp)	Selisih Jumlah yang dibayarkan (Rp)	Keterangan (Jika ada Selisih Pembayaran)

Demikian berita acara rekonsiliasi dibuat, untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pihak BPJS Ketenagakerjaan

Pihak Pusekesmas

(nama kepala kantor cabang)

(.....)

Jabatan :

Jabatan :

V. Dokumen Penyampaian Informasi Kelengkapan dokumen Tagihan Biaya Pelayanan Kesehatan

INFORMASI KELENGKAPAN DOKUMEN TAGIHAN BIAYA PELAYANAN KESEHATAN

NOMOR : .../.../...

Pada hari ini tanggal....., bulan....., tahun, Puskesmas, mengajukan tagihan biaya pelayanan kesehatan kepada BPJS Ketenagakerjaan Cabang, untuk klaim bulan pelayanan, Tahun, dengan rincian sebagai berikut:

Jenis Pelayanan	Jumlah Kasus Pengajuan**	Dokumen Lengkap (Kasus)	Dokumen tidak Lengkap (Kasus)	Keterangan
UGD				
Rawat Jalan				
Rawat Inap				
Perawatan lainnya				
Jumlah				

Dokumen lengkap akan dilakukan verifikasi oleh PIHAK PERTAMA sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dokumen yang tidak lengkapkasus, untuk dapat dilengkapi paling lambathari.

Demikian berita acara ini dibuat, untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pihak BPJS Ketenagakerjaan

Pihak Puskesmas

(nama kepala kantor cabang)

(.....)

Jabatan:

Jabatan:

** detil nama pasien terlampir

PIHAK KEDUA
(NAMA FASILITAS KESEHATAN)

PIHAK PERTAMA
BPJS KETENAGAKERJAAN
KANTOR CABANG

(NAMA)
(JABATAN)

(NAMA)
KEPALA KANTOR CABANG

LAMPIRAN IV
PERJANJIAN KERJA SAMA
TENTANG
PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN
BAGI PESERTA PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA

Nomor: PER/ ... /.... (nomor PIHAK PERTAMA)
Nomor: (nomor PIHAK KEDUA)

BENTUK PAKTA INTEGRITAS PLKK

PAKTA INTEGRITAS
(Nama PLKK)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Kepala Rumah Sakit ...

NO	NAMA	NIK	NO. TELP	ALAMAT EMAIL YANG VALID	MASA PENUGASAN	
					TMT	TAT

2. Petugas penanggungjawab pada Aplikasi e-PLKK sebagai berikut:

NO	NAMA	NIK	NO. TELP	ALAMAT EMAIL YANG VALID	MASA PENUGASAN	
					TMT	TAT

3. Petugas penanggungjawab administrasi sebagai narahubung BPJS Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut:

NO	NAMA	NIK	NO. TELP	ALAMAT EMAIL YANG VALID	MASA PENUGASAN	
					TMT	TAT

Dengan ini menyatakan bahwa:

- a. Dalam menggunakan *user login* untuk melakukan entri data pada Aplikasi e-PLKK akan menjaga kerahasiaan dan tidak memiliki niat dan/atau melakukan tindakan untuk kepentingan pribadi atau tujuan melakukan sesuatu untuk manfaat sendiri, maupun menguntungkan pihak-pihak yang terkait serta tidak memiliki potensi benturan kepentingan (*conflict of interest*) termasuk dengan seluruh pihak yang terlibat dengan tindakan diatas.
- b. Dalam waktu 1x24 jam akan melaporkan ke BPJS Ketenagakerjaan apabila terdapat pergantian petugas entri baik dikarenakan pindah tugas maupun adanya putus hubungan kerja.
- c. Berkomitmen untuk melakukan pekerjaan secara profesional atas dasar kejujuran dan bertanggung-jawab terhadap hasil pekerjaan yang telah disepakati dengan BPJS Ketenagakerjaan
- d. Melakukan tindakan pencegahan korupsi, gratifikasi, suap dan kecurangan.
- e. Berkomitmen menjaga kerahasiaan informasi BPJS Ketenagakerjaan dan tidak menyalahgunakan untuk kepentingan lain.
- f. Pakta integritas ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa menyembunyikan fakta dan hal material apapun dan saya bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dari hal-hal yang saya nyatakan di sini. Demikian pula akan bersedia bertanggung jawab baik

secara hukum apabila pernyataan ini tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya.

Demikian Pakta Integritas ini kami tanda tangani untuk digunakan sebagaimana mestinya.

....., 20...

KEPALA/PIMPINAN/DIREKTUR

**PENANGGUNGJAWAB
USER**

**PENANGGUNGJAWAB
NARAHUBUNG**

NAMA LENGKAP
JABATAN

NAMA LENGKAP
JABATAN

NAMA LENGKAP
JABATAN

*) TMT: Terhitung Masuk Tanggal

*) TAT: Terhitung Akhir Tanggal

PIHAK KEDUA

(NAMA FASILITAS KESEHATAN)

PIHAK PERTAMA

**BPJS KETENAGAKERJAAN
KANTOR CABANG**

(NAMA)

(JABATAN)

(NAMA)

KEPALA KANTOR CABANG

Nomor: PER/ ... /... (nomor PIHAK PERTAMA)
Nomor: (nomor PIHAK KEDUA)

PIHAKE PERTAMA BPJS Ketenagakerjaan Alamat Kantor Alamat web : <u>www.bpjsketenagakerjaan.go.id</u> Nomor Telp/faks Petugas yang dapat dihubungi (PIC) Jabatan..... No HP : Alamat email :	PIHAKE KEDUA Alamat Kantor ----- Alamat web : (apabila ada) Nomor Telp/faks Petugas yang dapat dihubungi (PIC) 1. PIC Administrasi Jabatan No HP Alamat email	2. PIC Klinis Jabatan No HP Alamat email
---	--	---

PIHAK PERTAMA
BPJS KETENAGAKERJAAN
KANTOR CABANG

(NAMA)
KEPALA KANTOR CABANG